

안이비인후피부과학1 3주차 써머리

목차

0. 과목 안내

I. 피부외과학의 개념

II. 피부외과학 발달사

A) 중국에 있어 피부외과학의 역사적고찰

B) 한국에 있어 외과학의 역사적고찰

III. 외과질환의 명명 및 분류

A) 외과적 질병의 명명 특징

0. 과목 안내

1. 수업

: 안이비인후피부과학은 1학기 피부과 박민철 교수님께서 수업하시고, 2학기 안과와 이비인 후과를 홍석훈 교수님께서 수업하십니다. 이 중 1학기 피부과 박민철 교수님께서 중간고 사 이전까지 수업을 하시고, 중간고사 이후에는 조별과제 발표를 수업으로 대체하시며 **기말 고사 시험은 따로 보지 않고** 발표 점수를 기말고사 과제 점수로 대체하십니다. 중간중간 CASE REPORT를 소개하시는데 수업 내용과 관련 없는 경우가 많습니다.

2. 출석

: 교수님께서 출석은 자율에 맡긴다고 하셨는데 3주차부터 출석을 부르셨으나 출석에 크게 신경을 쓰시지 않는 것 같습니다. 중간고사 이후 발표 수업에는 18학번 기준으로 출석도 거 의 안 부르시고 발표하는 조만 있는 경우가 많았다고 합니다.

3. 시험

: **중간고사는 100% 객관식**으로 출제하시며, 거의 답치기가 가능할 정도로 무조건 악마를 탄다고 합니다. 수업 써머리와 시험이 아예 무관한 수준에 가까워 본 써머리 본문 중간중간 에 문제들만 정리하였으며, 답과 해설은 시험 대비 파일에 따로 정리하였으니 참고하시길 바 랍니다. CASE REPORT의 경우 시험 내용과 관련 있는 내용만 정리하였습니다.

* 써머리 양식: **피피티 빨간색** / 교수님 추가 설명 / **기타 강조 개념** / **악마**

I. 피부외과학의 개념

- ^{소우주}小宇宙 환경의 차이로 사람마다 모두 다르다. Ex) 1층에서 3층을 왔다 갔다 하면 힘든 정도가 다르다.
- ^{음양오행}陰陽 五行 간은 ^음결음(족결음간경)이나 기능은 양이다. (간양상향) → 양속의 음, 음속의 양을 생각
- ^{칠정육욕음식상타박상}七情 六淫 飲食傷 打撲傷 과거에는 감염성 피부질환이 가장 큰 문제였다. → 시대적 상황 고려
- ^{외과내과}外科에서도 ^{맥상음양허실한열표리}內科와 마찬가지로 병세나 脈狀을 陰, 陽, 虛, 實, 寒, 熱, 表, 裏에 따 라 ^{보탁소도공독제}補託이나 消導 및 攻毒劑를 적당하게 사용하였고, 외부적 ^{농창옹저}膿瘡이나 癰疽만을 중요 시하지 않았다.
- ^{한방피부외과}韓方皮膚外科는 ^{피부표면}皮膚表面에 나타난 증양이나 ^{피부병근골경부}皮膚病만 아니라 筋骨이나 臟腑 및 ^{조직}組織에 생긴 ^{종양일체}腫瘍 一切를 ^{약물요법}藥物療法이나 ^{절개수술}切開手術이나 ^{외용약}外用藥 등을 사용하여 질병을 예방하고 치료하며 연구하는 학문이다. 최근에는 MPS나 필링 등을 도입하여 외치요법 위주로 함

II. 피부외과학 발달사

A) 중국에 있어 피부외과학의 역사적고찰

1) ^{상고시대}上古時代

[黃帝內經素問 異法方宜論篇第十二]

第一節

黃帝問曰 醫之治病也, 一病而治各不同, 皆愈何也?

岐 伯對曰 地勢使然也.

故^{동방}東方之域, 天地之所始生也, 魚鹽之地, 海濱傍水, ^{기민식어이기합}其民食魚而嗜鹹, 皆安其處, 美其食 魚者使人熱中, 鹽者勝血, 故其民皆黑色踈理, 其病皆爲^{음양}癰瘍, 其治宜^{편석}砭石. 故砭石者, 亦從東方來.

: 동방(해안가)에 사는 사람들은 **어업이나 짠 음식**을 많이 먹어 생기는 **뽀루지(화농성 여드름)**가 많이 생겨 **편석**을 이용해 **농**을 빼는 치료를 한다.

☞ 異法方宜論에서 동방지역의 사람이 창양 치료를 위해 사용한 방법은? / 이법방의론에서 其民食魚而嗜鹹으로 인해 생긴 창양치료를 위해 사용한 방법은? / 이법방의론에서 음식을 먹는데 있어嗜鹹한 사람의 창 역을 치료하기 위해 사용한 방법은? (15, 14, 13, 12)

第二節

^{서방}西方者, 金玉之域, 沙石之處, 天地之所收引也, 其民陵居而多風, 水土剛強.

其民不衣而褐, 薦其民, ^{화식이지비}華食而脂肥, 故邪不能傷其形體, 其病生於^내內, 其治宜^{독약}毒藥.
故毒藥者, 亦從西方來.

: 서방(고비 사막)에 사는 사람들은 양고기를 많이 먹어 성인병, 당뇨 등 내인성 질환이 많이 생겨 약으로 치료를 한다.

第三節

^{북방}北方者, 天地所閉藏之域也, 其地高陵居, ^{풍한빙설}風寒冰冽.

其民樂野處而乳食, ^{장한생만병}藏寒生滿病, 其治宜^{구설}灸燔.
故灸燔者, 亦從北方來.

: 북방에 사는 사람들은 추위로 인해 소화기 질환이 생기며 뜸을 이용해 치료를 한다.

第四節

^{남방}南方者, 天地所長養, 陽之所盛處也, 其地下, 水土弱, 霧露之所聚也, 其民^{기산이식부}嗜酸而食附,

故其民皆纖理而赤色, 其病^{력비}癰痺, 其治宜^{미침}微鍼.
故九鍼者, 亦從南方來.

: 남방(열대우림)에 사는 사람들은 덥고 습한 기후로 발효 음식을 많이 먹었는데 그로 인해 당뇨성 질환, 마비성 질환이 생겨 침을 이용해 치료를 한다.

第五節

^{중앙}中央者, 其地平以濕, 天地所以生萬物也衆.

其民^{식잡이불로}食雜而不勞, 故其病多^{위결}痿厥寒熱, 其治宜導引按蹻.

故導^{도인안교}引按蹻者, 亦從中央出也.

故聖人雜合以治, 各得其所宜.

故治所以異而病皆愈者, ^{득병지경}得病之情, 知治之大體也.

: 중앙에 사는 사람들은 움직이지 않아 무력증이 생기므로 마사지로 치료를 한다.

2) ^{하상주춘추전국시대}夏, 商, 周와 春秋戰國 時代

(1) 殷商시대 - 갑골문자

- “疾自(鼻病), 疾耳, 疾齒, 疾舌, 疾足, 疾止(指족趾), 疥, 瘡” 기록.
- 湯液, 祝由나 주문

(2) ^{문헌상}文獻上 ^{최초}最初의 ^{외과}外科醫 : ^{유부}俞跗

(3) 周나라 의료제도 : ^주食醫 ^주疾醫 ^주瘍醫 ^주獸醫

(4) 『周禮·天官』

- ^양瘍醫의 기록 존재 → 瘍醫는 腫瘍, 潰瘍, 金傷과 折瘍 등 ^{외과}外科질환을 주로 치료.
- 敷藥法 割除術 去腐生肌藥

(5) ^한漢나라 ^{마왕퇴}馬王堆의 ^{한묘백서}漢墓帛書 『^{오십이방}五十二病方』

- 중국의 현존하는 최초 의학문헌
- 52種의 各科疾病에는 感染, 創傷, 凍瘡, 諸蟲咬傷, 痔漏, 腫瘤, 皮膚病 등 포함.
- 治療方面 - 주로 藥物 사용. 灸法, 砭法, 熏洗, 洗法.

(6) 『^{황제내경}黃帝內經』

- ^{외과}外科病症의 ^{병인병기}病因病機를 중요하게 간술

“膏粱之變 足生大丁” / “汗出見濕 乃生座痂” / “^{한기화위열}寒氣化爲熱 ^{열승즉부육}熱勝則腐肉 ^{육부즉위농}肉腐則爲膿”
한기(감염)가 들면 열이 발생한다. 심한 경우 조직의 괴사가 유발되고 농이 찬다.

- 病名 기록 : <癰疽篇> - 猛疽 失疽 腦癰 疔癰 米疽 馬部狹癰 甘疽 脫疽 등.

- 治療원칙 : “^{한자열지}寒者熱之 ^{열자한지}熱者寒之” 寒은 피부색을 의미한다.

- 治療방법 : 針砭 按摩 膏外用藥.

- 최초의 ^{절지수술}截趾手術로 ^{탈저}脫疽 치료 기록.

탈저는 손끝 발끝이 썩어서 떨어져 나가는 것으로 현대 버거씨병(폐색성 혈관 혈전염)에 해당한다.

최초의 ^{절지수술}截趾手術로 ^{탈저}脫疽의 치료가 실린 서적은? (12)

3) 秦漢 時代

(1) 漢·張仲景 『傷寒雜病論』

- 孤疔, 寒疔, 腸癰, 蛔厥, 癰疹, 浸淫瘡, 孤惑病 고혹병은 현대 베체트병과 유사하다.
- 大黃牧丹皮湯, 薏苡附子敗醬散 - 腸癰 치료

(2) 華陀

- 麻沸散으로 全身麻酔
- 腹腔 腫物 切除

전신마취를 통해 치료한 의가는? (12)

4) 魏晉南北朝 時代

(1) 晉末 『劉涓子鬼遺方』 진나라 말기에 이르러 다양한 치료 방법을 통해 접근하였다.

- 140개 處方
- 金瘡, 癰疽, 皮膚病 등 기재
- 內治 : 活血化瘀와 清熱解毒 위주
- 外治 : 薄貼法, 圍藥法, 洗搗法, 熏法 등의 各種 劑型 外用藥 사용.
- 癰大堅者 未有膿 半堅半薄有膿 當上薄者都有膿. 便可破之.

옹은 크고 단단하면 농이 아직 없는 것이다. 반 정도가 단단하고 얇으면 반 정도 농이 생긴 것이다. 윗부분이 얇은 경우는 농이 모두 생긴 것이니 펴서 터뜨릴 수 있다.

(2) 晉·葛洪 『肘後備急方』

- 癰病 치료 : 海藻 癰病은 현대 갑상선 질환에 해당하는 병으로 해조류에 포함된 아이오딘(I)을 쉽게 섭취할 수 없었던 서방 지역의 사람들이 많이 앓는 병이다. 갈홍의 『주후비급방』에는 해조류를 이용한 갑상선 질환의 치료가 최초로 기술되었다.

해조를 이용한 癰病 치료법이 쓰여진 서적은? (09)

5) 隋唐 時代

(1) 隋 - 『諸病源候論』 外科 관련된 9권

- 癰疽瘡腫과 皮膚疾患, 折傷金瘡 19門, 300餘論
- 疥瘡 : 乾과 濕 구분, 病因 - “皆有蟲”所致 개창(음)의 원인은 진드기(蟲)다.
- “多手足之間 染漸生至于身體 痒有膿汁”
- 金瘡腸斷候 : 腸吻合術, 血管結紮法 제시
- “先以針縷如法 連續斷腸” / “當以生絲縷系絕其血脈”

다음 중 피부외과학에 있어 제병원후론에 기록된 내용으로 조합된 것은? (미상)

(2) 『千金要方』

- 癰疽 骨疽 丹疹 疥癬 등의 脈因證治 경험 기록
- 천금요방은 금궤요략의 계열(증상-질환-처방의 구성)로 되어있다.
- 軟膏, 硬膏, 糊膏, 水劑, 酒劑, 油劑, 薰藥, 水銀製劑 등 劑型 포괄
- “氣胸” “驗透膈法” → “驗透膈法” - 葱管을 利用하여 小便을 보게 하는 방법

6) 兩宋 金元 時代

- : 外科術이 開刀방법에서 藥物치료로 전환되기 시작하는 시대
- : 病機분석상 전체와 국부 관계 중시
- : 치료상 扶正과 祛邪를 결합, 內治와 外治 결합 중시.

(1) 『太平聖惠方』

- 제60-68卷의 痔, 癰, 皮膚, 癰癰 등
- 五善七惡說 제기 - 瘡瘍의 예후 판단 근거 제공.

(2) 진자명 『外科精要』

- 外科用藥시 經絡의 虛實을 살펴서 치료
- 熱毒이 안으로 공격하면 寒凉克伐之劑 사용

(3) 金元時期·劉完素

- 『素問玄機原病式』 『宣明方論』
- 外科病 치료에 苦寒藥을 광범위하게 응용. 고한약을 쓴 것은 熱者寒之(2p)의 개념이다.

(4) 他基于

- “膏粱之變, 足生大丁”
- 外科病 위치가 表에 있으나 실은 裏에서 발생된다는 관점 제기.
- 瘡을 다스리는 요점은 “托里, 疏通, 行榮衛”
- 後世外科의 “消, 托, 補” 3大法의 기초가 됨.

소법은 소염시키는 것, 탁법은 농을 밀어내는 것, 보법은 생肌(새 살을 돋게 하는 것)시키는 것

창양의 3대 치법은? (11)

(5) 이고 李杲 이동원

- 이미 潰膿한 癰疽에 → 健脾하여 肌肉을 生하게 하는 법 강조.
- 黃芪肉桂柴胡酒煎湯을 써서 堅硬漫腫을 치료. 본 처방에서 酒는 식초를 의미한다.
- 明代 薛己의 『外科發揮』와 陳實功의 『外科正宗』으로 계통적 발전.

★ 正宗派의 계통적 발전과정: 이고 李杲 → 설기파 薛己派 → 정종파 正宗派 → 금감파 金鑑派

정종파의 계통적 발전과정에 포함되지 않는 의가는? (14, 13, 12)

정종파의 潰膿 후 건비하기 위한 처방은? / 이미 潰膿한 癰창에 肌肉을 건비하는 정종파의 처방? (17, 15)

피부외과학에 있어 동원을 중심으로 하는 계통적 발전에 있어 해당사항이 없는 것은? (미상)

(6) 주진형 朱震亨 『丹溪心法』 주단계

- 癰疽의 발병과 6陽經, 6陰經의 氣血多少관계 분별.

명청시대 7) 明清 時代

(1) “薛己派”

- 『薛氏醫案』
- 外科 방면 著述: 『外科發揮』 『外科心法』 『外科樞要』 『外科經驗方』
- 溫補學派의 선구자 → 脾胃를 중시하여 溫補藥을 잘 사용.
- 瘡瘍은 本末虛實을 밝혀야 한다고 강조.
- 체질과 환경적 요인, 음식, 정서 등을 고려해야 한다.
- 內治法을 중시하여 溫補에 뛰어났고 → 때에 따라서는 刀針之術을 시행

(2) “正宗派”

- 陳實功 『外科正宗』
- 內外科法을 모두 중시하여 刀針과 藥物의 結合을 제창
- 內治法면: 東垣학설 영향으로 “外科에서 脾胃를 조리하는 것이 중요하다” 강조
→ 活血化瘀나 清熱解毒의 방법을 동시에 응용 → 補托法을 더욱 중시
- 外治法면: 外科手術 발전에 공헌
→ 頰關節整復法, 氣管縫合術, 指關節離斷術, 腹腔穿刺排膿術, 鼻息肉摘除術

(3) “金鑑派”

- 『醫宗金鑑·外科心法要訣』에서 “正宗派”의 학술사상을 계승 발전.
- 內外科法을 아울러 중시.
- 消, 托, 補의 三法으로 內治法면의 중요성을 명확히 했다.

(4) “^{전 생 파}全生派”

- 王洪緒 ^{외과전생집}『外科全生集』 / 許克昌 ^{외과증치전생집}『外科證治全生集』

- 陰陽辨證原則를 창립: ^{음양변증원칙}외과질환을 ^{창립}陰陽으로 구별 → 癰: 陽症 / 疽: 陰症

양증은 눈에 보이는 체표면의 모낭염, 화농성 여드름 등이며 음증은 골수염, 고관절염 등 체내의 질환

- 陰疽의 인식과 치료에 있어서는 독창적.

→ ^{백저}白疽는 ^{음허지증}陰虛之證으로 ^{기혈}氣血이 ^한寒하고 ^혈血이 ^한凝했다는 이론에 기초.

백저는 음증이므로 체표면에 색의 변화가 나타나지 않는다.

- “陽이 조화롭게 腠理를 통하도록 氣血을 溫補해야”

→ ^{양화탕환창제}陽和湯(丸) 創製

→ 犀黃丸, 醒消丸, 小金丹 창방

- ^{도침}刀針 등 수술요법에 반대하는 국한성 반영

→ “消함에 貴함이 있고 托함에 두려움이 된다.”

☞ 외과질환을 음양변증원칙에 입각하여 치료하였고 음저의 인식과 치료에 있어서는 독창적인 이론을 제시하였으며 도침 등 수술요법에 반대하는 의견을 제시한 학파는? / 도침과 약침을 결합해서 쓰던 학파와 무관한 학파는? (14, 12)

(5) “^{심 득 파}心得派”

- 高錦庭 ^{양과심득집}『瘍科心得集』 / 余聽鴻의 ^{외과회안회편}『外科醫案匯編』

- ^{내과}內科의 이치에 따라서 ^{창안}瘡瘍을 치료하는 것이 특징

- 溫病三焦學說의 영향을 받아 ^{외과삼부변증원칙}外科三部辨證原則를 창제

증상만 없고 사람이 없는 것이 한계

① 上部: 風熱, 風溫 ② 下部: 濕火, 濕熱 ③ 中部: 氣鬱, 火鬱

- 溫熱病 치료를 파악하여 方藥과 함께 瘍科에 포함시킴.

→ ^{서각지황탕}犀角地黃湯, ^{자설단}紫雪丹, ^{지보단}至寶丹으로 ^{정창}疔瘡, ^{주황}走黃 치료

주황은 한 부위에 생긴 감염성 피부질환이 덧나서 점점 심해져 결국 패혈증(sepsis)에 이르는 것

☞ 온병삼초학설을 계승한 학파는? / 온병삼초학설의 영향을 받아 외과 삼부변증원칙을 창제한 학파는? (17, 15, 14, 13)

☞ 외과학의 계통적 발전과정에 해당되지 않는 사람은? (09)

B) 한국에 있어서 외과학의 역사적고찰

1) ^{고려}高麗 - 고려 말기에 출판된 ^{향약구급방}鄉藥救急方

2) ^{조선}朝鮮 - ^{외과의}外科醫의 ^{분과}分科는 ^{침구의}鍼灸醫, ^{나력}癰癰醫, ^{치종}治腫醫

- 1433년 노중례 ^{향약집성방}鄉藥集成方

- 1447년 ^{의방유취}『醫方類聚』

- 成宗~中宗: 金順蒙은 ^{침과}針과 ^약藥으로 ^{종창}腫瘡환자 치료

- 明宗: ^{임언국}任彦國은 ^{치종의}治腫醫로 유명. <治腫指南>저술

- 宣祖: 全有亨은 해부학 발전에 기여 → ^{허준}許浚 ^{동의보감}『東醫實鑑』 ^{외형편}外形篇, ^{옹저편}癰疽篇

- 顯宗: 白光炫은 ^{치종교수}治腫教授로 유명

- 純祖: 李宜春은 <瘍醫微>라는 ^{외과}外科方 저술

☞ 조선 명종 때 治腫醫로 활동한 의가는? (12)

III. 외과질환의 명명 및 분류

A) 외과적 질병의 명명 특징 참고

- 形態: 蛇頭疔, ^{아장풍}鵝掌風 손바닥 습진

- 臟腑: 腸癰, 肺癰

- 病因: 凍瘡, 漆瘡, 破傷風

칠창은 옷 알레르기, 광범위하게는 접촉성 피부염

파상풍은 깨진 상처로 풍(원인균)이 들어왔다는 의미

- 症狀: 翻花瘡, ^{황수창}黃水瘡 노란 진물이 계속 흐름

- 穴位: 人中疔, 委中毒

- 部位: 腦疽, 發背, 肘癰, 足踝疽

- 색깔: 丹毒, ^{백전풍}白癰風, 白喉 백전풍은 현대 백반증에 해당함

- 疾病特性: 爛疔, 流注 난정은 논일하다가 상처로 균이 들어와서 빠른 속도로 괴사되는 것

- 範圍와 大小: 癰과 癰 절은 3cm 미만의 뽀루지(모낭염) / 웅은 절이 2~3개 모여서 합쳐진 상태

안이비인후피부과학1 4주차 써머리

목차

IV. 피부의 구조와 기능

- A) 피부구조
- B) 표피를 구성하는 세포
- C) 표피부속기
- D) 진피
- E) 피하지방층
- F) 피부표면의 지질
- G) 표피 장벽
- H) 피부의 투과성
- I) 노화

V. 피부외과의 생리

- A) 皮膚外科學의 生理
- B) 치료원칙
- C) 皮와 臟腑, 經絡과의 관계
- D) 피부의 보호기능
- E) 피부의 기타기능

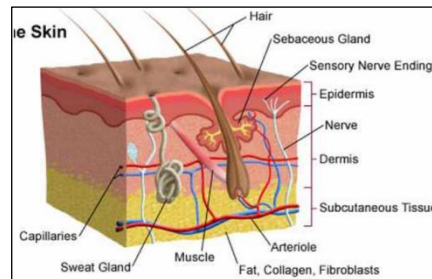
VI. 피부외과학의 진단 및 변증

- A) 피부증상과 증후

IV. 피부 구조와 기능

A) 피부구조

: 피부는 3개의 층으로 구성된다.
(표피 / 진피 / 피하지방층)



B) 표피를 구성하는 세포

1) 각질형성세포(Keratinocyte) 물리적, 화학적 보호기능 / 표피세포의 90~95%

- 표피의 구조(5층): 淺 각질층 > (투명층) > 과립층 > 유극층 > 기저층 深

① 각질층(horny layer)

: 피부의 가장 바깥에서 피부를 외부의 자극으로부터 보호해준다. 핵과 생명력이 없는 죽은 세포이다. 표피의 가장 바깥에 위치하며, 각화된 세포와 먼지, 피지 등과 함께 수분함량을 조절하는 역할을 한다.

② 투명층(stratum lucidum)

: 과립층과 각질층 사이의 경계를 이룬다. 생명력이 없는 무핵의 투명한 세포이다. 2~3개 층으로 주로 손과 발바닥에 분포되어 있다. 엘라딘이라는 반유동적 단백질이 빛을 굴절시켜 빛을 차단하고 수분침투를 방지하며 윤기를 부여한다.

③ 과립층(granular layer)

: 2~5개의 층으로 케라토히알린은 케라틴단백질이 뭉친 것으로 주성분은 단백질, 핵산, 지질과 당분이다. 피부방어 역할, 세포 내에서 빛을 굴절 반사시켜 자외선의 60%가 흡수된다. 피부 내부로부터의 수분증발을 저지하고 피부병과 피부건조를 방지한다. 과립층 자체도 피부 건조에 큰 역할을 하는데 과립층과 과립층형성세포 사이에는 tight junction이 있어 수분의 이동을 막는 역할을 한다.

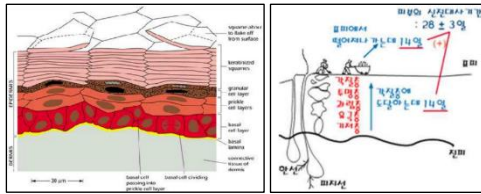
④ 유극층(prickle layer)

: 표피의 대부분을 차지하는 가장 두꺼운 층이다. 5~10층의 다각형 세포로 구성된다. 핵과 세포 사이에 림프액이 있어 표피의 혈액순환과 영양공급에 관여하는 물질대사가 이루어진다. 세포분열이 활발하지 않지만 유극층을 다칠 경우 표피 손상을 복구할 수 있다. 기저층과 유극층의 차이는 손상의 복구 유무이다.

⑤ 기저층(basal layer)

: 진피와 경계를 이루는 물결모양의 단층이다. 세포분열을 일으켜 새 세포를 형성한다. 진피의 혈관과 림프관을 통해 영양을 공급받는다. 기저층의 기질형성세포 모세포가 손상되면 세포재생이 어려워 흉터가 남는다. 케라틴을 만드는 각질형성세포와 피부색을 좌우하는 멜라닌형성세포가 있다.

- 기능: 각화 / 면역기능 관련물질 생산



: 기저층에 존재하는 기질형성세포 모세포에서 생성된 새 세포가 각질층까지 도달하는데 14일이 걸리고, 각질층에 존재하는 세포가 표피에서 떨어져 나가는데 14일이 걸려 **피부의 신진대사기간은 28일 ± 3일**이 걸리게 된다.

☞ 손바닥 표피층의 구조는 몇 개의 층으로 구성되는가? (15, 14, 12)

☞ 손발바닥에만 존재하는 표피층은? / 손발바닥을 제외한 신체 모든 부위에서 epidermis(표피)의 구조가 아닌 것은? (13, 09)

☞ 표피의 구조 중 천연보습인자가 존재하는 layer는? (미상)

☞ Keratinocyte(각질형성세포)의 구조에 해당하지 않는 것은? (11)

☞ 각질형성세포의 정상적인 신진대사 주기는? (12)

☞ 각질세포가 기저층에서 발생해서 각질층에 도달하는데 걸린 시간은? / 각질형성세포가 기저층에서 발생하여 각질층까지 가는데 걸리는 시간은? (18, 17, 09)

2) 멜라닌 세포(Melanocyte) 광선에 대한 보호기능

- 표피의 5%, 주로 기저층에 존재

- 멜라닌 색소를 함유한 멜라닌소체(Melanosome)를 합성.

- 피부가 자외선에 노출되거나 정신적 인자, 호르몬 변화 등을 감지

→ 멜라닌세포의 크기 확대, 멜라닌세포의 수상돌기 증식현상

- 멜라닌세포의 수는 인종, 피부색에 관계없이 1,200~1,500개로 동일.

- 피부색은 멜라닌세포 내의 멜라닌세포 수와 크기, 멜라닌화의 정도 및 각질형성세포 내에서의 멜라닌 분해에 의해 결정.

- 검은 피부는 흰 피부에 비해 멜라닌소체의 양이 많으며 유극층의 상부까지 멜라닌소체가 분해되지 않고 넓게 퍼져 있다.

- 멜라닌 종류: 유멜라닌 검정, 갈색 - 흑인 다 페오멜라닌 분홍, 선홍색 - 백인 다

☞ 멜라닌 세포가 존재하는 곳은? (12, 11)

☞ 멜라닌 세포에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (18, 17, 15, 14, 13)

☞ 피부색을 결정하는 것과 관련이 없는 것은? (11, 10, 09)

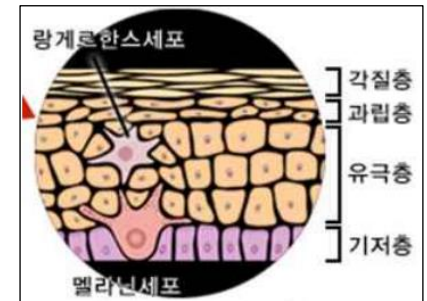
3) 랑게르한스 세포(Langerhans cell) 면역학적 보호기능

- 표피세포의 2~4%를 차지하는 별 모양의 수지상세포로 주로 유극층에 분포.

- 구강 및 생식기점막, 상피와 림프절, 피지선, 한선, 유선, 모낭세포에도 존재.

- 피부의 면역학적 반응과 알레르기 반응에 관계하는데 외부의 이물질인 항원이 피부에 침투하면 즉시 반응하여 면역담당세포인 림프구로 전달해 준다.

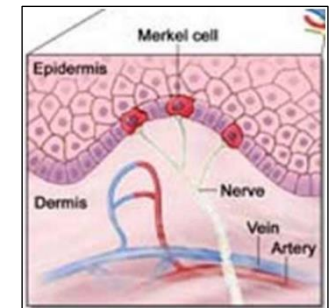
☞ 유극층에 주로 존재하는 수지상 세포로 피부의 면역학적 반응과 알레르기 반응에 관여하는 것은? (18, 17, 15, 14, 12)



4) 촉각 세포(Merkel cell) 촉각에 대한 보호기능

- 표피에 광범위하게 퍼져 있으나 주로 기저층 부근에 존재하며 촉각수용체로서 촉각을 감지.

- 인체의 피부에서 손바닥, 발바닥, 입술 등의 모발이 없는 피부에서 발견된다.



C) 표피부속기

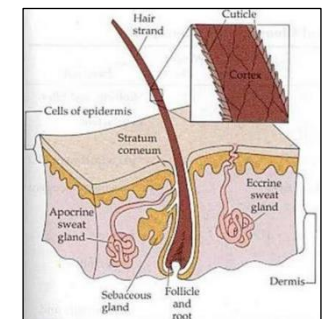
1) 에크린한선

- 존재부위: 손바닥 / 발바닥 / 겨드랑이 / 이마

- 기능: 체온조절, 환경 순응, 정서적 자극에 반응

- 땀의 분비기전: 열과 정서적 자극이 가장 중요 요소. 콜린성 신경의 지배 받음.

영향을 주는 '熱'은 햇빛과 같은 열 이외에도 배가 부르고 등이 따사다 할 때의 열과도 관련이 있다



D) 진피

- 불규칙성 치밀섬유 결합조직
- 두께는 0.5mm~4mm 정도, **표피의 10~40배** 되는 두꺼운 층으로 실질적인 피부
- 피부를 지지하는 탄력성과 관련
- 진피는 표피에 비해 세포가 많지 않으며 모양도 변하지 않는다. 그러나 **일단 손상이 되면 재생이 불가능하며 흉터가 남게 된다.**

1) 구성세포

: **섬유아세포** / 대식세포 / 비만세포 / 림프구 / 형질세포 / 백혈구

섬유아세포가 거의 대부분이며 이외에는 면역 관련 세포가 주를 이룬다. (피부의 보호 기능)

2) 기능

- 표피를 영양, 지지
- 외부 손상으로부터 보호
- 수분 저장
- 체온 조절
- 감각 수용체
- 표피와 상호작용해서 피부 재생

3) 교원섬유(collagen fiber)

- 진피의 주성분
- 섬유아세포에서 생산
- 창상치유와 반흔형성에 중요

4) 탄력섬유(elastic fiber)

- 섬유아세포에서 생산, 탄력 제공

5) 기질

- 진피의 섬유성분과 세포들의 사이를 채우는 무정형의 세포 외 물질
- 점다당질(mucopolysaccharide)이 주성분
- **진피건조 중량의 0.2%이나 수분을 자신의 1000배 함유할 수 있어 염분과 수분 균형에 기여.**

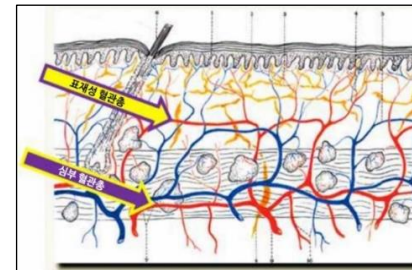
→ 결합조직 지지, 대사 조절

진피건조 중량의 0.2%에 해당하는 점다당질로 구성된 기질은 수분을 몇 배까지 함유할 수 있는가? (09)

6) 혈관

- ① **표재성 혈관층**: 유두진피와 망상진피의 경계부 표피까지 뻗어 일부 표피에도 영향을 준다
- ② **심부 혈관층**: 망상진피 하부
- ③ **연락 혈관**: 표재성 혈관층과 심부 혈관층 연결

하나가 막혀도 다른 곳에서 순환이 되고 영양분과 산소의 공급이 가능하다.



7) 신경

- 구성
 - ┌ 지각신경: 동통 / 소양감 / 온도 / 촉각 / 압각 / 진동
 - └ 자율운동신경: 피부의 혈관운동 / 모발운동 / 땀분비조절
- 특수신경 말단기
 - ┌ 점막피부말단기: 섬세한 촉각 전달 (입술, 성기)
 - └ **Meissner 소체**: 촉각 전달 (손바닥, 발바닥, 손가락 끝)
 - └ Vater-Pacini 소체: 압각 전달 (손바닥, 발바닥의 피하지방)

진피층의 구성성분이 아닌 것은? (12)

진피층에 존재하며 손과 발바닥, 손가락 끝에서 촉각을 전달하는 특수신경 말단기는? (12)

E) 피하지방층

- 지방층의 분포와 두께는 **신체 부위, 성별, 연령, 영양 상태에 따라 다르며** 복부와 둔부에서는 3cm 이상으로 두껍고 눈꺼풀, 귀, 음경, 음낭 등에는 발달이 미숙하다.
- 기능: 열 격리 / 충격 흡수 / 영양 저장 / 미용

F) 피부표면의 지질

1) 피부표면 지방 구성성분

- **피지선과 각질형성세포**에서 생산
- 성분

: **cholesterol** / triglyceride / monoacylglycerol / diacylglycerol / **fatty acid** / wax ester / squalene / sterol / sterol ester / **ceramide**

주로 콜레스테롤 / 유리지방산 / 세라마이드가 1:1:1의 비율로 구성되는 경우가 많다.

나이가 많은 분들이 겨울철에 다리 같은 곳이 하얗게 일어나는 건성 습진의 경우 콜레스테롤 관련 지질 성분이 부족한 경우가 많다. 피부 산성도는 pH5.5로 약산성인데 유리지방산이 pH를 조절하는 역할을 한다. 세라마이드가 부족해지면 피부장벽에서 시멘트 역할을 하는 것이 부족해져 아토피 피부염이나 알러지에 노출되기 쉬워진다.

📌 과립층의 층판소체에서만 생산되는 피부 표면의 보습인자는? (12)

📌 세포가 분화할 때 fatty acid, cholesterol, ceramide의 비율은? / Lamellar body가 과립층에서 각질층으로 분화하는 과정에서 발생하는 fatty acid, cholesterol, ceramide의 비율은? (18, 17, 15)

2) 피지선 분비 기전

- ① 피지선 세포의 주기는 **2~3주로**, 피지선 세포가 죽기 **8일 전에 피지 분비가 최고**에 달하며 androgen의 영향을 받는다. 모낭 내의 세균 및 남성호르몬을 타겟으로 하여 치료
- ② **세포 자체가 파괴되면서 분비**
- ③ 피지선에서 분비된 피지는 모낭을 거쳐 표피 표면에 도달할 때는 **모낭 내 존재하는 세균의 지방분해효소에 의해 유리지방산으로 만들어짐**. (염증, 여드름의 유발요인)

📌 피지선의 세포 주기는? (12)

📌 피지선 분비 기전에 대한 설명으로 틀린 것은? (06)

G) 표피 장벽 안과 밖을 나누는 역할

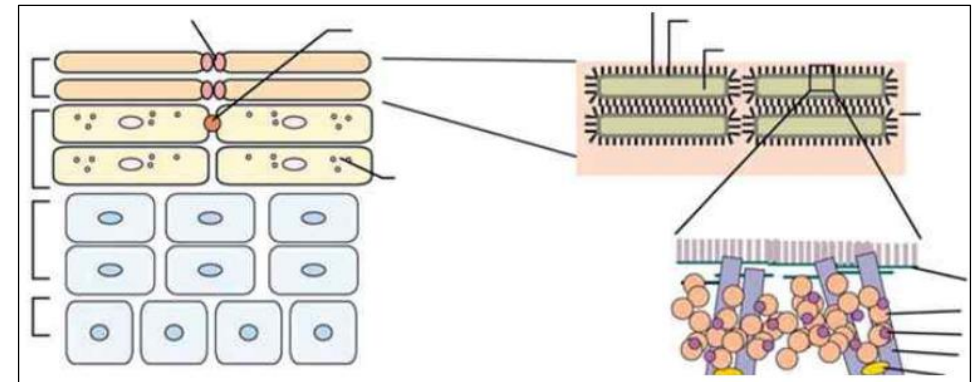
1) 구조

: 피부의 가장 상층부에 존재하는 각질층이 표피 장벽으로 작용

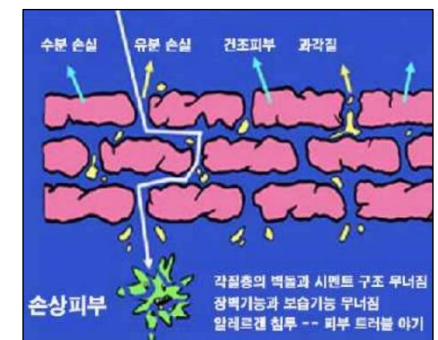
2) 기능

- 표피의 수분 증발과 손실 억제 과립층의 Tight junction은 수분 이동을 차단
- 표피의 정상적인 생화학적 대사를 할 환경 제공
- 피부 외부의 화학적, 물리적 손상으로부터 보호
- 세균, 곰팡이, 바이러스 등이 피부로 침범하는 것을 방지

📌 표피장벽 손상 시 나타나는 증상이 아닌 것은? (11, 10)



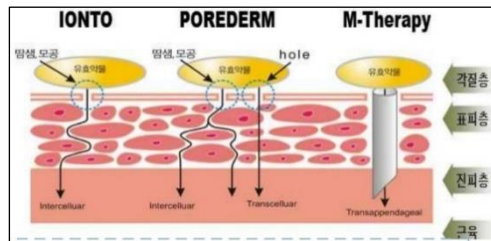
각질형성세포가 분해되면서 벽돌 역할을 하는 단백질을 형성한다. 이 벽돌을 잘 쌓는 역할이 필라그린이라는 물질인데, 선천적으로 필라그린이 부족한 사람은 벽돌 사이에 구멍이 난다. 아토피 피부염을 앓고 있는 환자 중 필라그린 발현이 잘 안되는 유전자를 가지고 있는 경우가 있다.



H) 피부의 투과성

: 각질층을 제외한 표피와 진피의 대부분 투과성이 높다

1) 경피흡수경로

① **각질층**을 통한 흡수: 농도차에 의한 흡수② **모낭과 피지선**을 통한 흡수: 분자량이 큰 물질이나 이온 등의 물질이 주로 확산 기전으로 흡수③ **에크린한선**을 통한 흡수

IONTO는 이온 전도법, POREDERM은 전기 충격을 통한 인지질 이중층의 개방, M-Therapy는 침이나 사혈을 통해 구멍을 내는 것으로 needle의 깊이에 따라 통증 유무가 다르다. 보통 0.5mm 정도면 통증이 없으나 부위에 따라 다르다.
(이마 - 0.5 / 턱 - 0.8 / 흉터 - 1.0)

④ 피부에 유효한 성분을 투여할 때 진피 내 흡수율이 가장 높은 방법은? (14, 12)

④ 유효성분을 흡수시킬 때 피부 흡수력이 가장 높은 방법은? / 피부에 유용한 약물을 투여하는 방법 중 흡수율이 가장 좋은 것은? / 피부유효성분 투여법 중 흡수율이 가장 높은 것은? (18, 17, 15)

Cf) Physical, Chemical

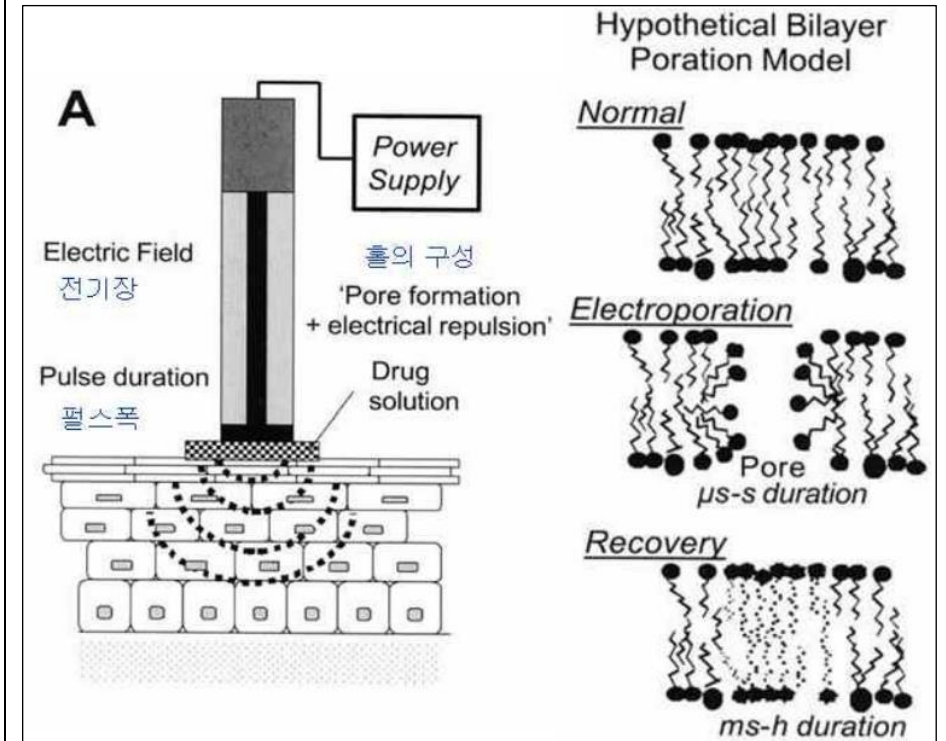
- 약물의 흡수율

: 피부에 유효한 성분을 피부에 투여하는 방법에 따라서 피부에 흡수되는 비율이 달라지는데 일반적인 방법으로는 다음과 같다.

종류	흡수기전	진피내 흡수율
일반화장품	피부 흡수보다는 피부 각질층의 보습 역할	가장 적다 (0.3%)
이온토시술	피부의 1% 정도를 차지하는 땀샘, 모공을 통한 약물 투여 (5,000 Dalton 이하)	중간 (10~15%)
포어덤시술	Electroporation을 이용한 가역적 약물투여 (40,000 Dalton 이하)	가장 많다 (50% 이상)

: Electroporation에 의한 약물투여를 위해선 피부의 홀열림의 사이즈에 맞는 40,000 Dalton 이하의 분자 무게여야 한다. 이렇게 개발된 솔루션을 직접 피부 깊이 투여하므로 그 효능을 극대화할 수 있는 것이다.

- Electroporation의 특징

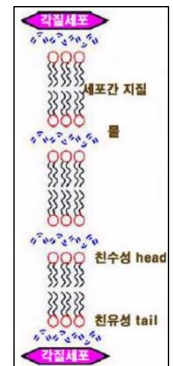


2) 경피 흡수에 영향을 주는 요인

- 흡수가 잘되는 요인

: **친지성 물질** / 피부에서 **수분량을 증가**시키거나 **온도를 올려줌** / 가스화된 물질 / 얼굴이나 성기 등 각질층이 얇은 부분 / 유아나 노인 / 각질층이 없는 점막

- 흡수가 잘 안되는 요인

: **산도(pH)가 변하여 이온화가 촉진** / 손발바닥 / 피부 두꺼운 성인

3) 흡수 촉진제

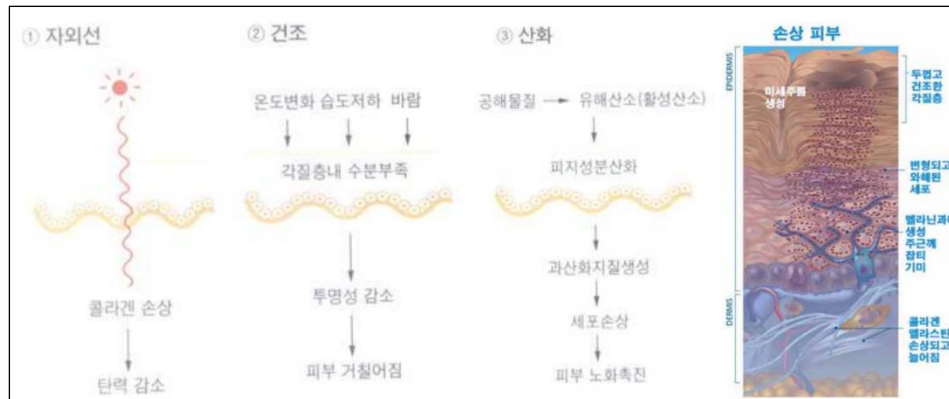
- ┌ 물리적 방법: 이온영동법 / 전기영동법 / MTS(AMTS)
- └ 화학적 방법: 각질층을 분해시키고 피부 수분량 증가 촉진

4) 밀폐요법

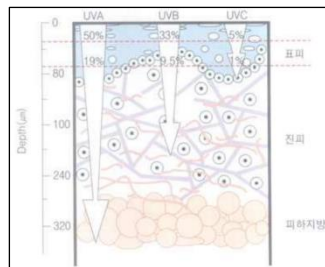
- ① 플라스틱 필름으로 밀폐: 피부의 수분 증발 억제, 각질세포의 부종 초래, 피부의 온도 상승, 경피 흡수를 급격히 향상
- ② 주의: 삼출액이 많은 병변은 병변 악화와 세균감염 우려

I) 노화

1) 노화의 원인 자외선 / 건조 / 산화



- 자외선에 의한 노화



- ┌ UVA: 파장이 길어서 진피층까지 도달
- ┌ UVB: 농사하시는 분이 주름이나 지연홍반이 있는 경우 치료
- ┌ UVC: 난치성 질환의 피부에 적당량을 쬌어 치료

Cf) 자외선에 의한 영향

자외선의 종류	침투 깊이	영향
UVA (320~400nm)	진피까지 도달	- 즉시 색소침착 / 지연홍반 - 광독성, 광알레르기 반응 - 유리기(free radical) 생성으로 인한 만성적 광노화 - 진피의 탄력섬유와 교원섬유의 변성으로 인한 피부 탄력성 감소 및 피부위축 현상, 주름형성, 일광탄력 섬유증 유발 - 백내장 유발
UVB (290~320nm)	표피 기저층 또는 진피 상부까지 도달	- 프로비타민 D를 활성화하여 구루병 예방 - 적당량의 경우 면역력 강화, 여드름 치유에 도움 - 피부각화 지속화 - 홍반, 수포, 일광화상(급성 반응) - 지연 색소침착, DNA를 손상시켜 피부암의 원인(만성 반응) / 즉각홍반 - 세포막 손상, 효소활동 감소 - 많은 양의 경우 면역력 저하, 여드름의 염증 악화
UVC (200~290nm)	오존층에 흡수, 피부에 도달하지 않음	- 살균작용, 박테리아 및 바이러스 등 단세포성 조직을 죽이는데 효과적

피부 노화에 가장 중요한 원인은? (14, 12)

- 건조에 의한 노화 건조와 관련된 물질

- ┌ 표피: NMF, 세포간 지질(콜레스테롤, 유리지방산 등)
- ┌ 진피: 용해성 콜라겐
- ┌ 기질: **히아루론산**

→ **수분보유력**이 좋아야 대사가 잘 일어나고 조직 파괴로부터 보호하며 피부가 거칠어 보이지 않는다.

V. 피부외과의 생리

별로 중요한 파트는 아님. 교과서에 있고 국시에 나올 수 있어서 하는 것...

A) 皮膚外科學의 생리

- 癰疽가 생길 때 그 行에는 處가 있고 그 主에는 歸가 있다. 응저 = 염증성 피부질환
(心: 喉舌 / 肺: 皮膚 / 脾: 肌肉 / 肝: 筋肋 / 腎: 骨髓에 발생)
참고만 할 것! 경향성은 있지만 꼭 그렇지 않다. 피부 질환에 반드시 폐경격을 쓰는 것도 아님!
- 陰毒: 下 / 陽毒: 上에서 발생
- 腑: 外 / 臟: 內에서 발생
- 下에서 발생한 경우는 緩慢 / 上에서 발생한 경우는 急速
- 腑에서 感한 것은 易治 / 臟에서 感한 것은 難治

B) 치료원칙

1) 十二經脈의 氣血多少 분포

- 多氣多血: 手陽明大腸經, 足陽明胃經
 - 多氣少血: 手少陽三焦經, 足少陽膽經, 足少陰腎經,
手少陰心經, 手太陰肺經, 足太陰脾經
 - 多血少氣: 手厥陰心包經, 足厥陰肝經, 手太陰小腸經, 足太陽膀胱經
- 血少한 경우 營血(포도당, 성장인자)가 부족해 새살이 차올라 impair 되기 어렵다.

2) 氣多者 行氣, 血多者 破血

- 氣少한 것은 起發하기가 어려우므로 補托.
- 血少한 것은 收斂하기가 어려우므로 滋養

3) 用藥할 때는 어느 經의 病인가를 먼저 辨別한 다음 風, 濕, 氣, 血, 痰, 陰虛 중에 證한 것에 따라 辨證治療.

4) 十二經脈의 補瀉 藥物 중에서

Ex) 手少陰心經: 當歸, 生地, 茯神 → 補 / 黃蓮, 枳實, 木香 → 瀉

C) 皮와 臟腑, 經絡과의 관계

① 皮와 肺

: 肺主皮毛 → 皮毛의 영양은 肺氣의 宣發작용에 의존

② 皮膚와 衛氣

: 衛氣는 皮膚와 腠理에 분포하며, 피부를 따뜻하게 하고, 영양을 공급

③ 皮와 經絡

: 部位별로 皮膚의 光택과 색깔 및 형태의 변화를 관찰하여 상응하는 臟腑와 經絡의 병변 파악

Cf) 한의학적 피부의 범주

: 膚腠, 玄府, 毛髮, 爪甲 등을 포함

① 膚腠(모공): 膚는 신체의 表皮, 는 肌肉의 紋理

② 玄府(땀샘): 汗孔, 鬼門

→ "(衛氣)者, 所以溫分肉, 充皮膚, 肥腠理, 司開闔" 국시 기출

③ 毛髮의 生化之源은 衝, 任脈의 2經과 관계

→ 毛色의 枯潤을 보고 臟腑의 병을 예측 가능.

1) 腎精虛怯: 營養을 할 수 없어 毛髮이 脫落하고 黃悴.

2) 血熱: 毛髮이 茂盛할 수 없어 少年白髮이나 脫髮.

④ "肝之合, 筋也; 其榮, 爪也."

→ 爪는 筋의 삭으로 肝經의 血氣와 유관.

한의학적 피부의 범주에 해당하지 않는 것은? (18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09)

피부에서 所以溫分肉, 充皮膚, 肥腠理의 역할을 담당하는 것은? (12)

()者, 所以溫分肉, 充皮膚, 肥腠理, 司開闔 (17, 15, 14)

D) 피부의 보호기능

1) 물리적 보호

- 외부로부터 압력 차단: 피하지방의 완충작용, 진피층의 탄력성
- 지속적이고 완만한 만성 자극: 각질층을 두텁게 하여 보호 → 굳은살

2) 화학적 보호

- pH5.5 유지: 피지, 땀의 분비로 밸런스 유지
- 물질통과 저지(외부로부터의 물질 유입, 내부의 물질 유출 동시에 저지)

3) 세균에 대한 보호

- 약산성 피지막(pH5.5): 정상적인 피부상재균의 수를 유지시킴
- 피부상재균 존재: 나쁜 미생물이 붙어 살 공간을 줄여주는 역할
- 각질 박리: 각질이 분리되면서 세균을 같이 가지고 떨어진다

📌 피부의 생리적 pH는? / 정상적인 피부 상재균 수를 유지하기 위한 피지막의 정상 pH는? (18, 14, 12, 09)

4) 광선에 대한 보호작용

- 각질: 광선 반사 / 멜라닌: 광선흡수
- 피부 노화의 70%가 자외선에 의해 발생한다.
- UVA에 의한 진피의 collagen, elastin 파괴에 의해 발생

E) 피부의 기타 기능

① 분비 작용

- 1) 한선 - 땀 분비
- 2) 피지선 - 피지 분비

② 흡수 작용

③ 감각, 지각 작용

④ 체온조절 작용

⑤ 호흡 작용

VI. 피부외과학의 진단 및 변증

A) 피부증상과 증후

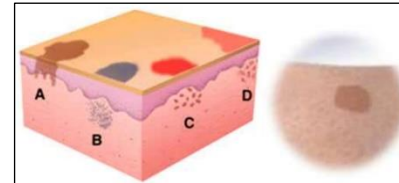
- ┌ 피부증상: 자각적 증상 → 피부의 가려움과 동통
- └ 피부증후: 타각적 증상 → 원발진과 속발진으로 구분

1) 원발진 原發疹(Primary Lesions)

: 피부질환의 **초기**에 볼 수 있는 병변

① 반점 斑點(Macules)

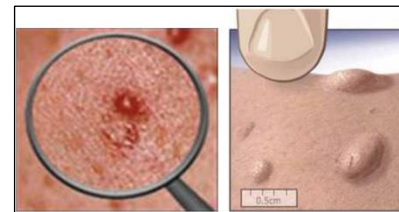
- 피부표면에 융기나 함몰이 없이 색조의 변화가 있는 것으로 대개 원형이나 타원형이고 경계는 명확하거나 주변으로 갈수록 색이 흐려진다.



📌 피부 표면에 융기나 함몰 없이 색조의 변화만 있는 원발진은? (12)

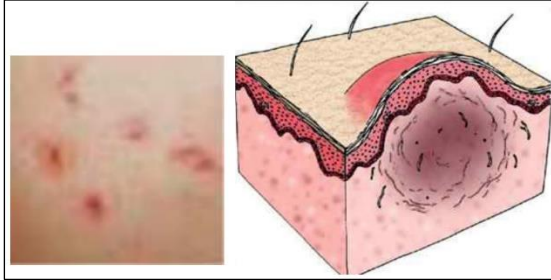
② 구진 丘疹(Papules)

- 경계가 뚜렷한 융기
- 직경 1cm 미만. 끝은 뾰족하거나 둥글다.
- 편평태선에서는 편평하고 전염성 연속종에서는 중심부가 함몰 편평태선 = 물사마귀
- 흰색(한진), 적색(습진), 흑색(흑색종) 흑색종은 피부암같이 까맣게 되는 것이다.
- 구진은 모낭의 개구부 또는 한선에 발생
- 병변 위치: 표피 및 진피 상부에 존재
- 구진이 커지거나 서로 뭉쳐서 형성된 넓고 편평한 피부 병변을 판(plaques)이라 부른다.



③ 결절 結節(Nodules)

- 결절은 구진과 같은 형태이나 **더 크고 깊으며** 일반적으로 **지속되는** 경향
- 구진이나 작은 종양 사이의 중간 형태
- **진피나 피하지방층의 병변에서 유래**



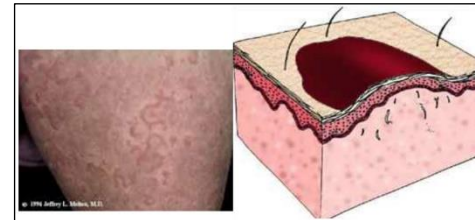
④ 종양 腫瘍(Tumors)

- 연하거나 단단하며 여러 가지 모양과 크기
 - 잘 움직이거나 고정된 덩어리
 - 융기되거나 깊게 존재
 - 섬유종에서와 같이 가끔 병(peduncle)을 이루기도 한다.
 - 어떤 종양은 정지 상태로 있으나 경우에 따라 감염과 괴사가 일어나 크기가 변화
- 지방종의 경우 정지 상태이다. 脂瘤는 피지선에 생기는 낭종으로 사혈하여 치료한다.



⑤ 팽진 膨疹(Wheals) 시작과 끝이 명확하다

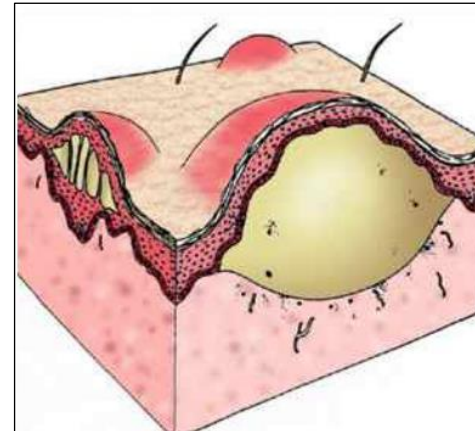
- 크기가 다양한 일시적이고 **부종성의 평평한 융기**
- 타원형 또는 불규칙한 모양
- 하나씩 떨어져 존재하거나 여러 개가 모여서 단단한 판을 만들며 수분 내에 생겨서 서서히 사라진다.
- 대부분 소양감 동반



65세 남성 10년 이상 두드러기 피부증상으로 볼 수 있는 것? (18, 17)

⑥ 대수포 大水疱(Bullae) 천포창과 같은 자가면역질환에서 다발

- 장액성 또는 장액농성의 액체를 포함
- 둥글거나 불규칙한 모양이며, 팽팽하거나 연약
- 소수포보다 크며 **1cm 이상의 수포를 대수포라 한다.**
- 대수포가 표피 하에 깊이 존재하면 팽팽하며 **궤양과 반흔**을 남길 수 있다.



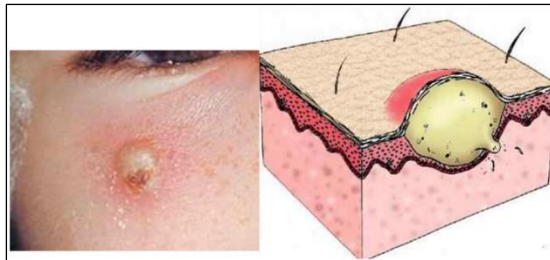
⑦ 소수포 小水疱 (Vesicles)

- 직경 **1cm 미만**의 맑은 액체가 포함된 물질
- 불규칙하게 분포하기도 하나 **대상포진**에서는 군집을 이루며 **덩굴궂나무** 피부염은 선상배열을 이룬다.
- 처음부터 소수포로 발생 또는 반점과 구진으로부터 생겨서 단시일 내에 자연히 터 지거나, 대수포를 형성하거나, 농포를 형성하기도 한다.



⑧ 농포 膿疱 (Pustules) 화농성 여드름

- 농포는 **농**을 포함한 피부의 작은 용기
- 모양은 수포와 비슷하나 대개 **염증성 유륜**을 보이며 단일 또는 군집으로 생긴다.
- 처음부터 농포로 생기기도 하나 구진과 수포로부터 생기기도 한다.



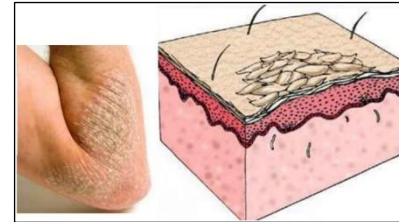
다음의 피부손상 증상 중 원발진에 해당하지 않는 것은? (10)

2) 속발진 續發疹 (Secondary Lesions)

: 속발진은 원발진이 계속 **진행**하거나 회복, 외상, 그 밖의 외적요인에 의하여 변화된 피부병변을 말하며 종류가 매우 다양하다.

① 인설 鱗屑 (Scales, Exfoliations, Squames) 아토피 피부염

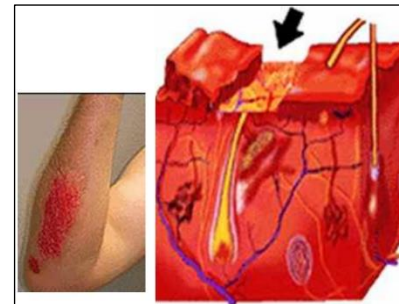
- 건조하거나 습한 **각질의 층상(laminates) 덩어리**
- 각질의 생성이 빨라지거나 정상 각질화 과정의 이상으로 박탈이 되어 발생
- **전풍**에서는 부드러우며, **습진&어린선**에서는 거칠고, **건선**에서는 두껍게 나타남
- 인설은 짧고 건조하며 부서지기 쉽고 광택이 있는 조각이지만 때에 따라서 피지와 땀이 섞여 번들거리며 불투명하게도 보인다.



전풍, 습진, 어린선, 건선에서 공통으로 나타나는 피부질환은? (09)

② 찰상 擦傷 (Excoriations, Scratch marks)

- 찰상은 소양성 질환에서 소양감을 제거하기 위해 손톱으로 긁은 후 또는 기계적 **외상**, 지속적인 **마찰** 등에 의해 생긴다.
- 드물게 유두상 진피에도 도달되나 대부분 상피에만 생기는 **찰과상(abrasion)** 형태



③ 구열 龜裂(Fissures)

- 어떤 질병이나 외상에 의해 표피에 생기는 **선상의 틈**으로 드물게 진피까지도 침범
- 염증과 건조에 의해 두꺼워지고 탄력성이 없어진 피부에 생긴다.
- 동통은 틈이 벌어지거나 찢어지면서 또는 새로운 균열이 생길 때 동반



④ 미란 糜爛(Erosions)

- **농가진이나 단순포진** 등에서 수포가 터진 후 **표피만 떨어져 나가** 생기며 이곳은 가피가 형성되거나 형성되지 않을 수도 있다.
- **반흔 없이 치유된다.**



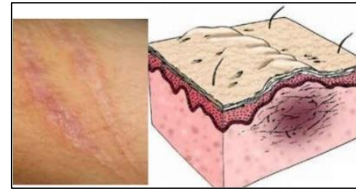
⑤ 궤양 潰瘍(Ulcers) 욕창과 같은 질환에서 많이 발생

- 궤양은 둥글거나 불규칙한 모양의 굴착으로 점진적인 괴사에 의해서 표피와 함께 **진피의 소실**이 오는 것
- 크기가 다양하며 **반흔을 남기며** 치유
- 잠식성 궤양: 피하지방까지 침범



⑥ 반흔 瘢痕(Scars, Cicatrices)

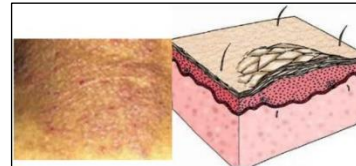
- 질병이나 손상에 의해 진피와 심부에 생긴 결손을 메우는 새로운 결체조직의 생성으로 생기며 **정상치유 과정**
- 모양이나 크기는 결손의 모양에 따라 결정
- 압력에 의해 얇고 **위축된 반흔**을 보이는 위축성 반흔도 있음
- **켈로이드**는 반흔 섬유들이 과다하게 자라서 형성된다.



㉮ 질병이나 손상에 의해 진피와 심부에 생긴 결손을 메우는 새로운 결체조직의 생성으로 생기며 정상 치유과정의 일종으로 모양이나 크기는 결손의 모양에 따라 결정되는 속발진은? (12)

⑦ 태선화 苔癬化(Lichenification)

- 표피 전체와 진피의 일부가 가죽처럼 **두꺼워지는** 현상
- 피부는 광택을 잃고, 유연성이 없어지며, 딱딱해지고, 피부주름이 뚜렷해진다.
- 만성 단순성 태선, 아토피 피부염, 결절성 양진 등의 **만성 소양성 피부질환**에서 흔하다.



Cf) 돌발 퀴즈

- **피부묘기증**에서 나타나는 증상을 무엇이라 부를 수 있을까요? **팽진**
- 다음과 같은 **화농성 여드름**은 피부질환 중 무엇에 해당하는가? **농포**
- 다음 사진과 같이 **좁쌀처럼** 생긴 피부질환은 무엇에 해당하는가? **구진**

㉮ 백색피부묘기증이 발생할 수 있는 질환은? (18, 17, 14, 13)

㉮ 여드름 피부에서 보이는 피부증후가 아닌 것은? (17, 15, 14, 13)

안이비인후피부과학1 5주차 써머리

목차

VII. 외과질환의 병리

A) 발병 원인

B) 발병 기전

VIII. 피부외과학의 병태생리

A) 염증의 정의 및 발생기전

B) 염증의 분류

C) 수복과 염증반응

D) 면역

IX. 피부외과학의 진단(문진)과 변증

A) 피부외과 질환의 사진

B) 증, 통, 양의 진단과 변증

VII. 외과질환의 병리

A) 발병 원인

1) 외감육음

- 外感六淫의 발병특징

→ 人體 抵抗力이 떨어지는 상태에서 感染.

→ 《內經》

“邪之所湊，其氣必虛” 코로나

“正氣內存，邪不可干” 백신

“風雨寒暑不得虛，邪不能獨傷人” 면역력

→ 六淫은 單獨으로 침입하기도 하지만 대부분 兼하여 病을 일으킨다. Ex) 풍한, 풍습

- 外感六淫의 계절별 특징

: 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절로 구분

① 봄: 風溫, 風熱이 많다.

(1) 風의 性質은 燥熱하고, 上行하는 性質이 많다.

(2) 扁桃腺의 腫瘡, 頸癰, 頭面丹毒, 疔腮 편도선염, 發頤 이하선염.

(3) 風邪의 특징

- 患處: 腫이 浮하고 患處가 紅 or 不變. 痛無定處, 流注 신속.

- 全身症狀: 惡風, 頭痛 수반.

② 여름: 暑熱이 많다. 환부에 홍반이 동반된 상태에서 심하면 진물이 흐른다.

(1) 暑는 반드시 濕을 끼고 發病.

(2) 疖, 瘡 한선염, 暑癰 모낭염, 暑濕流注 땀띠.

(3) 暑는 陽邪, 熱邪.

- 患處: 焮紅腫脹灼熱, 或痒或痛, 其痛遇冷則減, 糜爛流滋, 潰瘍出膿.

- 全身症狀: 口渴, 胸悶, 神疲乏力 수반.

③ 가을: 燥한 상태 無寒 不汗出(中景)

(1) 皮膚가 乾燥하여 龜裂이 쉽게 발생.

- 外邪가 侵入하여 癰이나 手足部の 感染 등의 疾病 초래.

(2) 燥邪의 특징: 手足, 皮膚粘膜 등의 부위가 쉽게 침범.

- 患處: 乾燥, 枯槁, 皸裂, 脫屑.

- 全身症狀: 口乾唇燥, 咽喉乾燥, 疼痛 수반.

④ 겨울: 寒의 性質이 많다. 한에 의해 생긴 피부병변은 색이 칙칙하고 어둡다.

(1) “寒主收引” - 局部的 氣血凝滯 초래.

(2) 凍瘡, 手足部 感染, 股와 腋部の 急性淋巴結炎

(3) 寒은 陰邪로 筋骨關節등에 侵入.

(4) 寒邪의 특징

- 患處: 紫靑暗色, 不紅不熱, 腫勢散漫, 痛有定處, 得暖則減, 化膿이 느리고, 膿水清稀

- 全身症狀: 惡寒, 四肢不溫, 小便清長 수반

- 총괄

- ① 동일한 계절에 동일한 外邪가 침범하더라도 인체의 虛實상태, 外邪의 침범부위, 지역적 특징에 따라 다른 疾病이 발생.
- ② 風寒暑濕燥邪 감촉 시 初期부터 염증의 紅熱현상이 나타나는 것이 아니고 中期에서 五氣가 過極하여 化熱生火하여 염증 발생.
- 결과적으로 “^{열독}熱毒” “^{화독}火毒”이 제일 많이 출현.
- ③ 外科 感染의 치료에서 “^{청열해독}清熱解毒”이 주가 되는 경우가 많다.

👉 피부외과질환에 있어 외사의 침범에 의해 결과적으로 제일 많이 보이는 변증 형태는? (12)

2) 外來傷害와 感染特殊之毒邪

- 外來傷害

- ① 跌撲損傷, 金刃, 沸水, 火焰 → 局部의 氣血凝滯, 熱勝肉腐

- 特殊之毒邪

- ① 蟲毒, 蛇毒, 瘋犬毒, 漆毒, 藥毒, 食物毒, 疫癘毒 Covid-19, 無名毒
- 毒邪의 種類
- ① 傳染性이 있는 病邪를 毒이라 한다.
- ② 天行時氣의 時毒 유행성 이하선염, 결막염, 독감 등, 牛馬疫畜의 疫毒 조류독감.
- ③ 無名腫毒: 病勢가 猛烈하던가 病情이 나쁠 때 明確한 病의 邪氣를 찾지 못한 것.
- ④ 觸毒: 칼이나 대나무에 찔려서 생긴 感染.

3) 情志內傷으로 인한 外科疾病의 공통특징

- ① 부위: 肝膽二經의 乳房, 胸脇, 側頸 부위에 호발.
- ② 증상: 患部腫脹, 或軟如饅, 或堅如石, 皮膚色不變, 疼痛極烈.
+ 精神抑鬱, 性情急躁, 易怒, 喉間有梗塞感.

- ③ 例) 瘰癧(頸部淋巴結核)

鬱怒傷肝 → 肝氣鬱結 → 鬱한 狀態가 오래되면 生火.

肝鬱 → 脾損傷 → 脾健運狀態 실조 → 痰濕 발생.

이렇게 형성된 氣鬱, 火鬱, 痰濕은 經絡을 막고 氣血을 凝滯시켜 덩어리를 만들며 瘰癧을 유발.

4) 飲食不節

- ① 기름기가 많은 음식, 술, 매운 음식을 多食.
→ 助火生熱하고 脾胃기능을 실조시켜 濕熱火毒이 발생.
- ② 飲食不節 + 外邪 感染
→ 癰, 疽, 疔瘡, 瘰癧, 酒齣鼻 등이 호발.
- ③ 全身症狀: 大便秘結, 胸腹飽脹, 胃納不佳, 舌苔黃膩 등 수반.
- ④ 外感으로 인한 外科疾病은 輕하고 臟腑蘊毒으로 인한 外科疾病은 重하다.
Ex) 糖尿病性 癰은 그만큼 治療가 힘들다.

5) 房室損傷

- ① 腎은 骨을 主管.
→ 腎虛하면 骨質에 營養障礙가 생기고 骨格이 약해지며 風寒痰濁이 骨格에 侵入하여 流痰(骨結核) 유발.
- ② 冲任失調 → 營血不足 → 生風生燥 → 風疹塊 발생.
- ③ 房室損傷의 특징은 대부분 慢性疾病
→ 病變이 깊어 骨과 關節에까지 침범하여 대부분 虛寒證

B) 발병 기전

1) ^{창 양 기 혈}瘡瘍과 氣血

① 瘡瘍 발생기전에서 氣血의 역할

: 氣血運行이 실조되어 患處의 ^{기 혈 응 체}氣血凝滯로 瘡瘍 발생.

② 氣血의 盛衰와 瘡瘍과의 관계

: “正氣内存, 邪不可干”

: 氣血이 충족한 상태에서의 瘡瘍은 쉽게 膿이 생기고 靨아 터져서 유합도 신속.

: 正氣가 虛하면 膿이 쉽게 생기지 않는다.

: 血少하면 靨아 터진 후 쉽게 아물지 않는다.

2) ^{창 양 장 부}瘡瘍과 臟腑

① 瘡瘍 발생기전에서 臟腑의 역할

: “凡瘡瘍, 皆由于五臟不和, 六腑壅滯, 則令經脈不通而生焉.” 《外科啓玄》

② 臟腑異常과 瘡瘍과의 관계

: ^{간 기 울 결 비 위 습 열 화 독}肝氣鬱結, 脾胃濕熱火毒 등은 瘡瘍을 유발 가능. (생활습관)

: “有諸內必形諸外” (유전적 소인 + 환경적 소인) (생활습관 + 외부감염)

: 病變이 비록 外部에 있더라도 그 根源은 內臟과 有關한 것.

(국소적 병변이 전신적 condition과의 연관성)

: 體表의 顔面疔瘡, 癰 등이 熱毒熾盛이나 氣血不足으로 인해 毒邪가 臟腑를 攻擊하여 走黃, 內陷(敗血症)을 일으켜서 毒氣가 心을 攻擊하면 神昏譫語 / 肺 → 咳嗽, 胸痛, 痰血

→ 瘡瘍 “五善”, “七惡”, “五損”: 臟腑 손상 여부로 예후 판단

병변이 어느 경락, 경혈에 있는지를 살펴서 치료하는 것도 중요하다.

단, 핵심은 치료해야 할 병변과 함께 전신 증상을 고려해서 치료해야 한다.

☞ 外科啓玄에서 瘡瘍의 발생에 관한 내용이다. 괄호 안에 해당하는 것은? (12)

VIII. 피부외과학의 병태생리

A) 염증의 정의 및 발생기전

1) **염증**이란?

- 손상에 대한 살아있는 조직의 반응.

- **손상을 국소화**시키고 손상된 부위를 **정상상태**로 되돌리려는 생체의 방어기전!!

- “**염증**은 조직에 손상이 가해져 시작되며 **회복을 위한 과정**이다” - Ebert

☞ Ebert가 정의한 조직에 손상이 가해져 시작되며 회복을 위한 과정은? (12)

2) **염증**의 5가지 증상: 發赤, 發熱, 腫脹, 疼痛, 기능장애① ^{발 적 발 열}發赤, 發熱

: 염증부위의 혈류가 증가하기 때문.

: 백혈구가 혈관 밖으로 이주하는데 도움을 준다.

② ^{종 창}腫脹

: 혈관 밖으로 혈장의 삼출 때문.

③ ^{통 통}疼痛

: 브라디키닌, 프로스타글란딘 같은 매개물질이 지각신경의 섬유말단을 자극하기 때문. 부종 때문에도 발생할 수 있음.

④ **기능장애**

: 동통에 의한 것으로 봄

B) **염증**의 분류

1) 급성염증

- 수분, 수시간 지속.

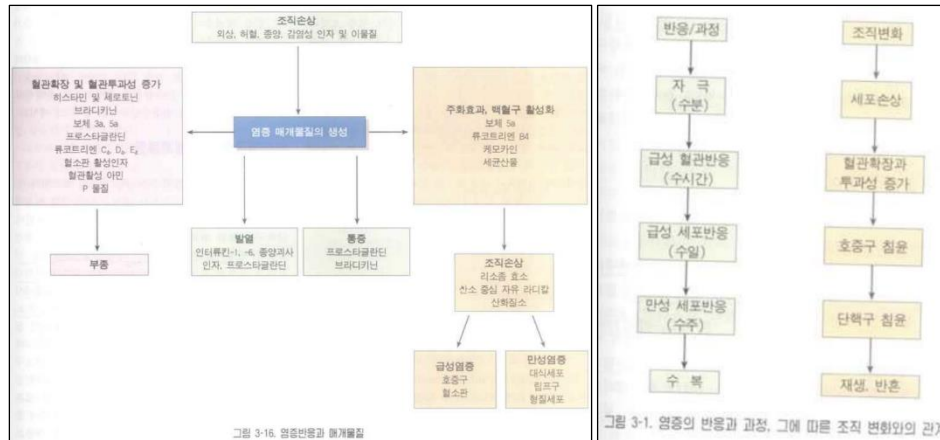
- **혈장의 삼출**과 백혈구(주로 **호중구**)의 이주를 특징으로 함

☞ Acute inflammation에 해당하는 사항은? (11)

2) 만성염증

- 기간이 길며 혈관과 결합조직의 증식이 특징. (재생)

- **림프구**와 **대식세포**의 침윤 및 결합조직의 증식을 특징으로 함.



(국가고사) 다음 중 만성염증에 관련된 것이 아닌 것은?

- ① 대식세포
- ② 림프구
- ③ 형질세포
- ④ 호중구

C) 수복과 염증반응

1) 수복(Repair)

- 염증의 과정 중 손상에 대한 반응 후에 뒤따르는 치유 과정.
- 수복과정에서 손상된 조직은
 - ┐ 원래의 실질세포로 대체(재생).
 - └ 섬유조직으로 대체(반흔).
- 재생과 반흔이 동반되는 경우가 많다.
- 염증과 수복은 연속적이며 중복.
- 넓은 의미의 염증: 조직이나 세포의 손상에 대한 즉각적인 반응으로부터 수복까지 기능적 및 형태학적 과정 전체를 의미.

교수님: 수복과정에서 손상된 조직이 원래의 실질세포로 대체되는 것은? 시험 내면 재밌겠조 들은 사람들 맞추고

2) 염증반응(inflammation response)

- 손상된 조직을 수복하는 유익한 방어반응.
- 감염의 경우 생명을 구해주는 역할.
- Sometimes) 생체에 오히려 해로운 결과를 초래(패혈증).

- 한방 피부외과학에서 감염에 의한 염증성 병변은?

→ **옹저**에 해당함.

옹은 피부의 천층에 발생하는 염증, **저**는 피부의 심층에 발생하는 염증.

- (靈樞·癰疽篇): 病因이 작용하면 **기혈**의 생리적 기능이 파탄되고 **氣血**이 물리게 되면 **통증**이 나타나고 부으며 **열**이 생기고, **열**이 생기면 皮肉이 썩어서 **膿**이 된다.

레이저/피부미용시술/상처 후 피부재생의 기전과 원리

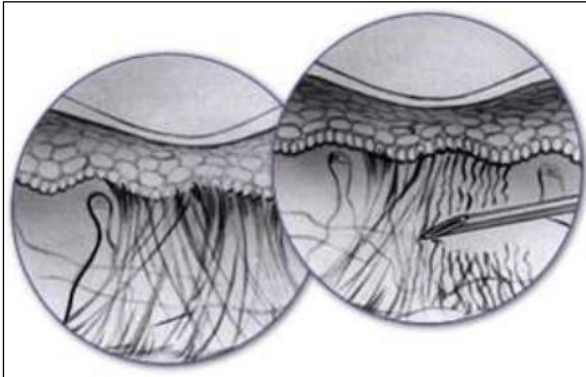


: 혈관을 통해 재생인자가 공급되어 환부의 재생을 유발한다. (대부분은 성장인자)

피부미용치료에 염증기전을 이용한다?? Wound healing

경과 기간	치료과정	창의 상태	치료
4~5시간 ↓ 3일	모세혈관의 투과성 개시 섬유아세포의 출현 유약(幼若)육아세포의 출현		적절한 창 치료
4~10일	섬유아세포 증식 표피화 완성	창면 접촉	발사 테이프 고정
1~3개월	콜라겐 증식 혈관 증식	창의 발적, 경화	창 압박 테이프 고정
4~6개월	섬유아세포와 신생혈관 감소	창의 연화 개시	테이프 고정
6개월~1년	반흔의 연화·안정화	창 고정	반흔 수정 시기

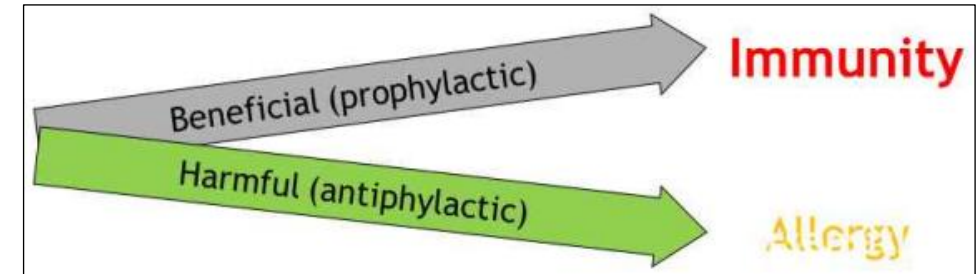
그림 4-1 창의 치유과정과 치료



D) 면역

〈면역이란?〉

: 병원미생물의 감염을 받은 개체가 미생물의 재차 **감염에 저항성**을 나타내는 현상.
면역과 알레르기는 동일한 면역반응이나, 숙주에게 해롭게 작용하는 경우 ‘알레르기’, ‘과민’이라고 한다.



1) 역대 문헌에서의 면역

- 〈明·免疫類方〉에서 최초 언급.

- 〈黃帝內經〉의 **정기** **正氣학설**

: “正氣存內, 邪不可干” “風雨寒熱 不得虛邪 不能獨傷人” “邪氣所湊, 其氣必虛”.

- 〈巢氏諸病源候論〉 漆에 대한 과민반응 언급

- 〈證治要訣〉 음식에 대한 과민반응

- 〈溫疫論〉 전염병에 대한 증족 간의 면역반응차이

2) 면역관련 피부외과질환의 종류

① 과민반응과 관련된 피부질환

: 浸淫瘡, 奶癰, 漆瘡, 藥毒, 隱疹

② 자가면역과 관련된 피부질환

: 白疔, 紅皮, 天庖瘡, 白駁風, 肌痺, 皮痹

3) 면역관련 피부외과적 질환의 원인

- 과민성반응, 자가면역질환, 면역결핍증후군

4) 면역관련 피부외과질환의 발생기전

① 제 I형 아나필락시스 과민반응

: 항원-항체 반응

: 즉시형 알레르기(10~20분)

: 두드러기, 꽃가루에 의한 알레르기서 비염, 천식, 위장 알레르기, 페니실린

② 제 II형 세포독성

: 세포 용해성 알레르기

: 용혈성 빈혈, 부적절한 수혈 시 나타나는 반응 천포창, 유천포창, 홍반성 낭창 물질

③ 제 III형 면역복합체

: 알레르겐 면역 복합체를 만드는 알레르기

: 원인 물질이 들어간 지 수시간 후 반응

: 신장염, 혈청병

④ 제 V형 자극성과민

: 항원에 특이항체 결합 후 발생하는 면역반응

: 조직 손상을 유발하는 것이 아니고 세포를 자극하여 활성화됨

⑤ 제 IV형 지연형 알레르기

: 항체가 아니라 림프구가 관계

: 24~72시간이 지난 후 반응.

: 옷, 접촉성 피부염, 투베르쿨린반응

⑤ 접촉성 피부염에 해당하는 것은? (18, 17, 15, 14)

⑤ 25세 남자가 새로 산 시계를 착용한 후 손목에 접촉성 피부염이 발생하였다. 면역반응 형태에 대한 진단은? (12)

⑤漆瘡과 관련된 면역반응의 형태는? (10)

⑤접촉성 피부염이 발생하는 피부면역 반응기전은? (09)

IX. 피부외과학의 진단(문진)과 변증

A) 피부외과 질환의 사진

1) 망진 望診: 육안적 관찰

① 皮膚 乾燥, 毛髮 乾燥, 痂皮 형성, 인체 곳곳에 발생.

→ 風病의 종류로 인식. (Ex: 四彎風)

② 피부상 白屑, 건조, 심한 搔痒感, 표피가 비후되는 것.

→ 癬病. (Ex: 건선)

③ 얼굴에 무수한 淡黃色的 點狀 발생.

→ 雀斑. (Ex: 기미)

④ 瘡腫이 손가락 사이에서 발생하며 심한 소양감.

→ 疥瘡. (Ex: 옴)

- 피부외과 질환에서 망진의 특징

: 피부에 발생하는 각종 질환은 望診을 통해서 진단이 가능하고 이를 토대로 하여 병명이 붙여졌음을 알 수 있고, 形色으로 보고 병의 원인과 속성을 파악하여 대처해 나아갈 수 있다는 사고가 한방 피부외과학에서 望診法의 독특한 면이다.

⑤진드기에 의해 생기며 심한 소양감을 느끼고 밤에 더 심해지는 것은? (18, 15, 14, 13)

① 望局部 병변

- 形色이 같지 않으면 證도 다르다.

- 局部 病變

: 瘡瘍에서는 形色을 살펴 寒熱과 性質 구분

㉠ 紅色 - 熱證 / ㉡ 白色 - 寒證 / ㉢ 青紫色 - 瘀血 / ㉣ 黑色 - 壞死

⑤창양에서 국소 병변의 형색과 한열의 성질에 대한 연결로 옳은 것은? (12)

② 望精神

- 望神은 환자의 정신상태 → 의식, 동작, 반응 상태 파악.

- 황련 - 분노(心胸大煩) / 복령 - 예민(悸) / 치자 - 슬픔, 걱정(心憤憤, 懊惱) / 용골모려 - 두려움, 겁이 많음(煩驚, 驚狂) / 지실 - 우울(或悸) / 시호 - 짜증, 긴장(煩, 悸而驚)

③ 望形態

- 患者 形態의 壯弱肥瘦, 動靜姿態, 疾病과 관계된 體位變化를 살피는 것.
- 마른 사람 → 陰血不足 → 相火上炎 → 潮熱 Ex) 瘰癧, 流痰

④ 望舌(舌診)

- 望舌 → 舌質과 舌苔, 舌의 形態를 관찰하는 것.
- 舌은 ^{심지묘비외후} 心之苗, 脾의 外候. ^{중요} / ^{태위기생} 苔는 胃氣가 生하는 바.
- 정상적 舌象 → 舌體柔軟, 淡紅舌, 薄白苔.
- 臟腑의 虛實, 氣血의 盛衰, 病邪의 淺深, 津液의 盈虧와 질병 예후의 판단 근거
- ^{설진} 舌診의 임상

(1) 舌質紅: 外科 急性病 중에 출현.

→ 주로 熱證. / 慢性病 중에 보이면 陰虛.

(2) ^{홍이기자자열} 紅而起刺者: 熱極 / ^{홍이건조자열} 紅而乾燥者: 熱盛, 津液不足.

(3) 舌絳: 邪熱이 營分에 들어간 것

→ 疔瘡走黃, 頭疽內陷.

(4) 舌質淡白: 氣血兩虛.

(5) ^{설반논치홍} 舌胖嫩, 齒痕(+): 氣虛, 陽虛

→ SLE 후기, 과량 호르몬 치료 후.

(6) ^{청자설어혈} 靑紫舌: 瘀血

→ 瘀血流注, 松皮癬의 瘀血證.

(7) 白苔: 外科疾病 + 表證 or 寒證. 脾胃濕.

(8) ^{황태} 黃苔: 熱邪蘊結 습열, 누르고 끈적끈적한 태

→ 瘡瘍化膿 단계.

(9) 膩苔: 濕重 / 白膩: 寒濕 / 黃膩: 濕熱(急性腹證)

(10) 黑苔: 寒熱의 구분

└ 熱者: 苔黑烏燥 → 熱極似火.

└ 寒者: 苔黑 薄濕潤 → 陽虛極寒, 命門火衰.

㉠ 아토피 피부염을 치료하기 위해 스테로이드 호르몬을 대량으로 복용한 후 보이는 설진의 양상은? (12)

㉡ 설진 청자설 진단? (09)

㉢ 설태를 생하는 바는? (12)

㉣ ()은 心之苗, ()의 外候 / 혀는 ()之苗이며, ()의 外候이다. (18, 17, 14, 13)

㉤ 45세 여성환자가 3일 전부터 헛바늘이 돌아서 침을 삼키거나 음식을 먹을 때 통증을 주소로 내원하였다. 변증은? (18, 17, 14)

2) 문진 聞診

① 聞診: 聽診 + 嗅診.

② 聽診: 환자의 聲音, 呼吸, 咳嗽, 嘔吐, 呃逆을 듣는 것. 기침소리

③ 嗅診: 환자의 분비물(膿液, 痰涕) 氣味를 냄새로 판별하는 것. 가래의 양상

3) 문진 問診

- 問診의 내용에는 現病력을 포함.

Ex) 환자의 주소증, 동반증상, 발병일, 발병 시 증상과 병정 변화, 발병의 원인과 誘因, 발병후의 치료경과(약물 or 수술치료, x-ray, Lab)

- 현재 질병과 유관한 p/h, f/h, 기호, 직업, 월경, 출산도 포함.

① 問寒熱

- ^{양증찰양} 陽證瘡瘍의 경우

(1) 發熱은 3期(上升期, 持續期, 下降期)로 구분.

(2) 瘡瘍病程의 初, 中, 後期와 일치.

: 初起에는 37.5 ~ 38℃ 사이 → 風邪外襲, 火毒內發.

Cf) 寒多熱少: 風寒表證. / 熱多寒少: 風溫表證.

: 中期發熱(38 ~ 39℃)은 持續的

→ 瘡瘍의 腫勢가 점차 확대, 化膿의 形象.

: 後期에 膿毒이 배설되면서, fever도 떨어져 정상 회복

② 問汗液

- 癰^옹癰^중症

- ┐ 땀이 나며 열이 떨어지면 → 邪氣가 땀을 따라 排泄되는 것.
- └ 땀이 나는데 熱이 떨어지지 않으면 → 邪盛한 것으로 膿이 形成되려는 徵兆

③ 問飲食

- 脾胃水穀의 氣로 氣血을 生하여 → 毒을 없애고 膿을 形成하여 生肌斂瘡.
- 瘡瘍 치료시 胃氣의 盛衰를 살펴 正氣強弱, 예후 파악.
- 風疹塊의 재발 → 생선, 새우, 게 유관

④ 問二便

: 二便은 毒氣를 빼는 중요한 통로

⑤ 問病因 or 誘因

♣ 질병 치료의 근본은 病因을 아는 것.

- 情志 → 乳房 結塊 → 久不解 → 乳癌.
- 漆器 접촉, 稟性不耐者 → 漆瘡.
- 針尖, 竹木, 魚骨에 찔리면 → 手足疔瘡, 類丹毒.
- 약물복용 후 → 稟性不耐者 → 약물성 피부염.

⑥ 問過去歷

♣ 특정 질병의 감별, 진단, 치료와 예후 파악

- 肺癆를 앓았던 사람 → 流痰, 癰癤 의 確診.
- 폐결핵을 앓았던 사람은 경부 임파선 감염을 앓기 쉽다.
- 癰, 頭疽, 疔瘡 환자 → 消渴症(+) → 난치성.
- 肝腎 기능 손상된 者 → 黃藥子, 砒制劑 慎用.
- 약물복용 후 → 국소적 紅斑 → 固定藥疹

⑦ 問職業

♣ 어떤 질병의 발생과 직업은 밀접한 관계.

- 목공 手指 → 疔瘡.
- 기계제조 공장 직원 → 皮膚裂瘡.
- 목축업 or 피혁공장 직원 → 疫疔

⑧ 問月經

- ♣ 月經不調는 瘡瘍의 發生, 化膿, 潰瘍, 收斂에 직접적 영향.
- 癰瘡患者 + 月經過多 → 月經期間동안 瘡口 수렴(-) or 확대.
- 風疹塊 : 생리가 시작될 때 발생, 생리가 끝나면 소실

⑨ 問家族歷

- 疥瘡, 麻風, 白禿瘡, 肥瘡은 가족끼리 전염되어 발생.

📖 가족끼리 전염되어 발생할 수 있는 질환은? (12)

4) 절진 切診

- 脈診으로 正氣의 強弱, 病變의 淺深, 毒邪의 盛衰 파악.
- + 疾病의 변화를 관찰 → 治法.
- 觸診: 손의 감각으로 病變을 만져서 → 병변의 성질과 화농 여부 파악. 열감

B) 중, 통, 양의 진단과 변증

1) 辨腫 변증

- 腫: 각종 致病因素 → 經絡阻滯, 氣血凝滯를 일으켜서 발생.
- 腫勢의 緩急, 集散 → 病情의 虛實과 輕重을 診斷하는 근거.

① 병인에 따른 判別

- 火: 腫이 紅色. 皮薄光澤, 焮熱疼痛.
- 寒: 腫이 不硬. 皮色不澤, 不紅不熱. 항상 痠痛(+).
- 風: 漫腫宣浮. 流注, 無定處. 不紅微熱. 輕微한 疼痛(+).

Ex) 瘡風(血管性水腫), 癰疹.

- 濕: 腫이 皮肉重垂脹急, 黃水 출현. Ex) 脚癬染毒, 下肢急性濕疹.
- 痰: 腫勢가 綿綿 or 結核처럼 단단. 不紅不熱. Ex) 瘰癧, 流痰.
- 氣: 腫勢가 皮緊內軟. 喜怒에 따라 消長. Ex) 氣瘰, 疔.
- 鬱結: 腫勢가 돌처럼 堅硬 or 邊緣에 棱角. Ex) 癌, 石瘰.
- 瘀血: 腫이 脹急. 초기에 暗褐色. 후기에는 靑紫色을 띠다가 점차 黃色으로 변하며 소실. Ex) 外傷으로 생긴 瘀血腫.
- 虛: 腫勢가 平坦, 根盤散漫.
- 實: 腫勢가 高起하고 根盤收束.

☞ 혈관성 수종, 은진에 속하는 종창의 형태에 관한 병인은? (12)

② 부위와 색택에 따른 判別

- 발병부위 조직의 疏鬆과 치밀함이 腫의 正황에 영향
- 手掌과 足底 등의 조직은 비교적 疏鬆
- 腫勢가 蔓延하고, 腫이 다른 부위에 비해 크고 明顯.
- 手指部 조직은 치밀 → 局部 腫勢가 가뻗고, 통증 극렬.
- 대퇴부는 肌肉이 풍부 → 腫勢가 甚하지만 外觀상 明顯(-)
- 健側과 비교하고 大腿의 두께를 측정해야 정확한 진단 가능.

2) 辨痛 변통

① 통증원인에 따른 判別

- ┌ 熱: 皮色焮紅, 灼熱疼痛. / 遇冷하면 통증 감소.
- ┌ 寒: 皮色不紅, 不熱, 痠痛. / 得暖하면 통증 감소.
- ┌ 風: 통증이 無定處, 走注.
- ┌ 氣: 攻痛無常, 가끔 抽掣. / 喜則 輕微, 怒則 甚.
- ┌ 化膿: 腫勢가 急脹. 통증이 지속적인 如鷄. 손가락으로 누르면 中間이 軟한 느낌.-
- ┌ 瘀血: 초기에 隱痛. 微脹微熱. 皮色 暗褐色. 지속되면 皮色 靑紫色 + 脹痛.
- ┌ 虛: 喜按. 按則 통증 감소.
- ┌ 實: 拒按. 按則 통증 증가.

3) 辨痒 변양

① 소양의 발생원인

- ┌ 風, 濕, 熱, 蟲의 邪 → 皮膚肌表 侵入
- ┌ 血虛風燥 → 皮膚 失養하여 발생

☞ 소양감의 발생 원인이 아닌 것은? (09)

② 원인에 따른 分별

(1) 風性

- 走竄無定. 全身 搔痒. 긁어서 出血이 있어야 그치며 / 化腐(-) / 乾性.
- Ex) 牛皮癬(神經성 피부염), 白疔, 風疹塊.

(2) 濕性

- 浸潤하여 黃水. 表皮를 따라 蝕爛. 腐할수록 痒. / 濕性. 간혹 전염성(+).
- Ex) 急性濕瘡(傳染性-), 膿疱瘡(傳染性+)

(3) 熱性

- 焮紅灼熱하며 가렵다. 노출부위나 전신에 발생.
- 심하면 糜爛되어 진물이 흐르고 痂皮 形成. 전염(-).
- Ex) 과민성 질환

(4) 蟲淫

浸淫滿庭하고 ^{황수}黃水. 피부에 벌레가 다니는 것처럼 搔痒이 극렬. 전염성 높음

Ex) 疥瘡, 手足癬, 肥瘡, 白禿瘡

(5) ^{혈허}血虛

피부가 두터워짐. 건조 脫屑있으며 가려움. 드물게 미란되며 진물. 전염성은 없다.

Ex) 濕瘡, 白疔, 牛皮癬 등의 만성 피부염

📌 피부가 태선화, 인설, 건조를 보이면서 드물게 미란되어 삼출물이 보이면서 소양증을 동반할 때 변증은?

(12)

③ 발병경과에 따른 분별

(1) 瘡瘍作痒

: 頭疽, 疔瘡 초기

: 局所 腫勢가 平坦, 根脚散漫, 膿이 未化時. → 소양감(+).

: ^{독세}毒勢가 ^{치성}熾盛하여 병변이 발전하는 추세.

(2) 潰瘍作痒

: 潰瘍治療 후, 膿이 이미 흘렀고, 주변의 腫이 존재할 때. 혹은 괴사된 조직이 탈락하여 ^{새살}새살이 점차 생길 때 → 소양감(+)

→ 毒邪가 和하여 氣血이 충만하고 새살이 자라나 瘡口가 회복.

: 癰疽가 已潰한 후, 患部 焮熱. 소양감(+)

→ 膿區 不潔 → 膿液이 피부 浸漬.

→ 수은, 砒劑, 膏藥을 붙인 후에 피부 과민.

4) 辨農 辨膿

의 학 입 문 개 열 비 습 즉 불 능 부 괴 기 육 위 농
- 〈醫學入門〉“蓋熱非濕 則不能腐壞肌肉爲膿”

: 瘡瘍의 膿: ^{창양}熱勝 + ^습濕의 蒸釀 → 腐熟되어 膿 形成.

- 膿은 瘡瘍에서 消散되기 전에 나타나는 주요증상.

- 瘡瘍의 出膿 → 正氣가 載毒外出의 표현.

- 已潰한 후 → 膿의 形質, 色澤과 氣味 변화를 살핀 후 질병의 盛衰와 病程의 逆順을 진단 가능.

① 농의 유무 변별

(1) 有膿

: 누르면 灼熱하며 痛甚. 重按하면 더욱 痛甚. 腫塊가 軟하여

→ 손가락을 들면 원상으로 회복된다(^{즉응지}即應指).

(2) 無膿

: 누르면 微熱하며, 痛勢가 심하지 않다. 腫塊가 단단하며

→ 손가락을 들어도 회복되지 않는다(^{불응지}不應指).

② 농의 형질, 선택, 기미 변별

(1) 膿의 性質

: 稠해야 하고, 淸해서는 안 된다.

: 稠厚者는 ^{조후자}元氣 充만 / 淡薄者는 ^{담박자}元氣 쇠약.

(2) 膿의 色澤

: ^{황백}黃白하며 ^{질조}質稠하고, ^{선택}色澤 선명 → ^{기혈충족}氣血充足 → 좋은 象.

(3) 膿의 氣味

: 膿液은 ^{농액}淹氣해야 하고 ^{취기}臭氣가 있어서는 안 된다.

: 膿液의 質이 稠 + 腥味가 있는 경우 → 順證

📌 瘡瘍의 膿이 형성될 때 熱과 함께 동반되어야 하는 것은? (12)

📌 창양이 농으로 전화되는 병인은? (18, 17, 14, 12)

📌 농에 대한 설명으로 옳은 것은? (11, 10)

안이비인후피부과학1 6주차 써머리

목차

X. 피부외과학의 치료

- A) 외과질환의 내치법
- B) 외과질환의 외치법
- C) 침구치료
- D) 이료(理療)

X. 피부외과학의 치료

- 1.瘡瘍의 치료는 內治法과 外治法으로 구분.
2. 가볍고 얇은 부위에 발생하는 적은 瘡 → 外治法이 主. 內治法 배합
3. 심한 瘡瘍은 內治와 外治를 겸하는 것이 필수.
4. 局部와 全體가 같이 심하면 (疔瘡走黃, 疽毒內陷)
→ 심지어 內治가 되는 수가 경우도 있다.

A) 외과질환의 내치법

1) 내치법의 3대 치법

: 瘡瘍의 發展過程에 따라 初期, 成膿期, 潰後期의 3단계 구분.

① 治療

: 消法, 托法, 補法. (瘡瘍 內治의 三大法則)

(1) 消法: 初期의 治療原則 현대의 소염제, 항염제에 해당한다.

: 消散하는 약물로 初期 瘡瘍이 化膿이 되지 않도록 한다.

(2) 托法 (補托, 透托): 成膿期の 治療原則 농을 배출시키는 것

: 補托 - 氣血을 補益하는 藥物로 正氣를 도와서 毒을 밖으로 내보냄.

: 透托 - 毒이 盛하고 正氣가 아직 虛하지 않은 瘡瘍. 透托의 藥物로 化膿을 촉진하여 毒을 밖으로 배출하는 방법.

(3) 補法: 後期の 治療原則 흉터 없이 회복하는 것, 기혈 중에서는 기가 영향 다

: 瘡瘍이 潰한 후에는 虛한 상태. → 生肌작용을 촉진시켜 愈合하게 하는 방법

2) 내치법의 구체적 운용

① 解表法

: 解表發汗의 藥物로 邪氣를 밖으로 내어보내는 것.

: 邪氣도 風熱, 風寒의 구분 / 治法도 辛凉, 辛溫의 구별.

└ 辛凉解表方 → 銀翹散, 友邦解肌湯. 상한방: 마행감석탕

└ 辛溫解表方 → 荊防敗毒散, 萬靈丹. 상한방: 계마각반탕

- 適應症

└ 辛凉解表藥: 瘡瘍이 焮 紅腫痛, 皮疹이 紅色 + 外感風熱證

└ 辛溫解表藥: 瘡瘍이 腫痛痠楚, 皮疹이 白色 + 外感風寒證

㉮ 風疹塊(풍진괴)로 인하여 腫痛痠楚, 白色皮疹과 함께 외감풍한증이 보일 때 처방은? (12)

② 通里法

염증성 대사산물 및 다른 대사산물이 피부를 통해 배출되지 않을 때

: 瀉下 약물로 축적된 臟腑內의 毒邪를 배출소통.

→ 除積導滯 염증성 대사산물, 逐瘀散結 작약, 대황 → 瀉熱 → 瘡瘍을 消散하는 治法.

: 攻下(寒下)와 潤下法

└ 攻下法: 大承氣湯, 內消黃連湯, 涼隔散.

└ 潤下法: 潤腸湯

③ 清熱法

가장 많이 사용하는 방법

: 《素問. 至真要大論》“熱者寒之”

: 寒凉한 약물로 체내의 熱毒을 清解하는 治法.

: 熱의 盛衰와 火의 虛實을 分別해야 한다.

(1) 實火: 清熱解毒

(2) 熱이 氣分, 營分, 血分에 있을 때

┐ 清熱解毒方: 五味消毒飲

┐ 清氣分熱方: ^{황련해독탕}黃連解毒湯 일반적으로 가장 많이 사용하는 처방 중 하나

┐ 清營分熱方: 清營湯

┐ 清血分熱方: 犀角地黃湯

┐ 養陰清熱方: 知柏八味丸

┐ 清骨蒸潮熱方: 清骨散

대개 항균효과, 소염효과가 강한 약물인 황련, 황금을 다용한다.

(3) 陰虛火旺 : 養陰清熱

- 適應症

: 清熱解毒法 - 紅腫熱痛의 陽證에 적용. 瘡瘍중에서 癰, 疔, 有頭疽.

: 清氣分熱法 - 紅腫 or 皮色不變 / 灼熱腫痛의 陽證 瘡瘍에 적용. 피부 손상부위가

^{홍홍작열}焮紅灼熱하고 膿疱糜爛에 적용.

: 清血分熱法 - 焮紅灼熱하는 ^{난청}爛疔 궤저성 피부염, ^발發, 큰 부위의 ^{화상}火傷

혈분열은 피부장벽의 기능이 다 망가진 상태이다.

- 清熱解毒藥은 ^{살균}殺菌, ^{억균}抑菌, ^{항균}抗菌과 백혈구의 탐식능력을 증가시켜 消炎의 효과를 증가시키는 것으로 보고.

④ ^{온통법}溫通法

- 適應症

: 溫經通陽, 散寒化痰法 → 寒痰이 筋骨에 머물러 환처가 은은하게 痠痛(+), 漫腫불명

확, 不紅不熱, 口不作渴, 形體惡寒, 小便清利, 苔白脈遲의 ^{내한}內寒현상.

내한은 추위에 민감한 증상이 하루이틀이 아니라 최소 5년 이상 지속되는 경우

: 溫經散寒, 祛風化濕法 → 風邪寒濕이 筋骨에 침습하여 환처가 痠痛麻木, 漫腫, 不紅

不熱, 惡寒重, 發熱 輕, 苔白膩, 脈遲緊의 ^{외한}外寒現狀.

외한은 갑자기 감염에 의해서 생기는 것으로 대표적으로 감기가 있다.

: 陽和湯은 溫陽補虛가 主 → 체질이 비교적 약한 경우 사용.

: 獨活寄生湯은 祛邪하고 補虛을 겸 → 체질이 약하지 않을 때 사용.

[傷寒 301] ⑮ 少陰病 始得之 反發熱 脈沈者 (^{마황세신부자탕}麻黃細辛附子湯)主之.

⑤ ^{거담법}祛痰法 주로 경부 임파선(나력)에 사용

: 化痰軟堅의 藥物로 痰凝한 腫塊를 消散시키는 治法.

- 適應症

: 疏風化痰法 - 風熱挾痰證에 적용.

Ex) 頸癰의 結塊腫痛, 咽喉腫痛, 惡風發熱者에 사용.

: 解鬱化痰法 - 氣鬱挾痰의 病症에 적용.

Ex) 瘰癧, 肉癭 → 結塊堅實하고 白色으로 不痛 or 微痛 + 胸悶氣塞, 性情急躁

: 養營化痰法 - 體虛挾痰證에 적용.

Ex) 瘰癧, 乳癌 潰後

┐ 疏風化痰方: 牛蒡解肌湯 合 二陳湯.

┐ 解鬱化痰方: 逍遙散 合 二陳湯.

┐ 養營化痰方: 香貝養營湯.

⑥ ^{이습법}理濕法 삼출물, 부종 → 환부에 삼출물이 나오거나 부종이 있는 상태

: 燥濕 or 淡滲 의 藥物로 濕邪를 제거하는 治法.

: 治濕의 方法

┐ 上焦에 있을 때는 化하고 → 羌活 川芎 蒼朮

┐ 中焦에 있을 때는 燥하고 → 猪苓 茯苓 澤瀉

┐ 下焦에 있을 때는 利한다 → 防己 木通 滑石

방기는 종아리를 만져봤을 때 부어 있고 눌렀다 뺐을 때도 자국이 남는 경우에 사용

: 濕邪는 발병시 대부분 다른 病因과 같이 발생. → 熱 > 風 > 寒

⑦ ^{행기법}行氣法

：理氣藥으로 氣機를 疏通시켜서 消腫散硬止痛하는 治法.

：七情으로 肝의 疏泄機能이 장애를 받으면 ^{기울}氣鬱하고 ^{혈어}血瘀.

：逍遙散, 舒肝潰堅湯.

－適應症：癭, 瘤, 岩.

－白芍, 木香, 枳殼, 陳皮, 鬱金, 柴胡 등 理氣解鬱 藥물은 鎮靜作用이 있다는 실험적 보고.

－少陰病 其人或咳 或悸 或小便不利 或腹中痛 或泄利下重者 (^{사역산}四逆散)主之

⑧ ^{화영법}和營法

：和營活血의 藥물로 經脈을 소통시키고 血脈을 調暢하여 瘡瘍의 腫을 없애는 治法.

：和營活血은 피부병과 肛門病의 주요 治法의 一種.

：桃紅四物湯, 活血散瘀湯.

－適應症

└ 급성화농성 염증질환에서 ^{만성염증}만성염증 단계로 변화할 때 적절.

└ 피부병의 瘀血證候에 적용 → ^{결절}結節, 모세혈관확장, 紫癍

🔗 급성 화농성 염증질환에서 만성염증 단계로 변화할 때 사용하는 내치법은? (12)

⑨ ^{내탁법}內托法

：透托 및 補托의 藥물로 扶正達邪하여 瘡瘍의 毒邪가 깊은 곳에서 얇은 곳으로 나오게 하거나 빠른 시일 내에 化膿이 되게 하는 治法.

：托法은 透托法, 補托法으로 분류.

└ 透托法 - 透膿散(황기, 천궁, 당귀, ^{천산갑}天山甲, ^{조각자}皂角子)

└ 補托法 - 托裏消毒散(황기, 천궁, 당귀, 작약, 인삼, 백출, 복령, 후박, ^{조각자}皂角子, ^{갈경}桔梗, ^{백지}白芷, ^{금은화}金銀花)

⑩ ^{보익법}補益法

：《素問·至真要大論》“虛者補之”“損者益之”

：補虛扶正的 藥물로 氣血을 補益하여 **새로운 살이 나도록 도와주고 瘡口가 빨리 아물도록 하는 治法.**

：益氣方 - 四君子湯 / 養血方 - 四物湯 / 氣血具補 - 八珍湯 / 滋陰方 - 六味地黃湯 / 助陽方 - 附桂八味丸, 左歸丸

🔗 Peeling, MTS 등을 시행한 후 성장인자의 분비 촉진을 통해 피부재생작용효과의 증진을 위해 사용하는 내치법은? (12)

⑪ ^{양위법}養胃法

：養胃하여 氣血의 회복을 도와서 瘡口가 愈合되는 것을 촉진

－內治法의 具體的 運用의 總括

：환자의 전신과 국소 상황, 病程의 단계, 病程의 변화와 전개 상황을 살펴서 主症을 파악하여 治法을 세우고 處方을 구성하여야 치료효과가 올라간다.

🔗 창상의 초기 치료 방법 중 하나인 소법에 해당하지 않는 것은? (18)

B) 외과질환의 외치법

－Wet in Wet, Dry in Dry

삼출물이 있는 경우는 용액으로 치료하고 태선화, 인설, 건조 등의 병변은 수분이 최대한 적은 오일, 자운고 등으로 치료한다.

－동일한 피부병이라도 피부손상의 형태가 다르면 치료도 다르게, 피부병의 성질이 다르더라도 피부 손상 형태가 같으면 같은 치료법.

－외치법은 환자의 자각증상을 줄여주고, 손상된 피부를 신속히 회복시키고, 나아가서 외치법만으로도 피부병을 치료하는 것이 목적.

－외용제 국소치료는 병소에 화학적 및 물리적 작용으로 효과

→ 물리적 작용: 습윤, 냉각 및 보호작용

－외용제는 단순한 것을 선택하여 어느 약재가 효과가 있는지 판단.

🔗 피부외과학에서 외치법의 기본 원칙은? (09)

1) 외용약물의 사용원칙

① 피부염의 급만성 분류

(1) 급성 피부염

┐ 紅斑, 丘疹, 滲出液(-) → 洗劑, 粉劑, 溶液濕敷

└ 대량의 **삼출물(+)** or 極熱紅腫 → 溶液濕敷

(2) 아급성 피부염

: 滲出液 or 糜爛이 적고, 紅腫이 줄어들고, **인설**과 **결가**가 있으면 → 油劑

(3) 만성 피부염

: **침윤**과 **肥厚**가 있고 피부각화가 심하면 → 軟膏

② 감염이 있으면 먼저 清熱解毒, 抗感染劑를 사용하고, 감염이 제거된 후에는 원래 피부손상 형태에 맞는 약물 사용

☞ 삼출액이 많은 급성 아토피피부염의 병변에 사용할 수 있는 외치법은? (12)

2) 外用藥物劑型

① 溶液

(1) 방법

┐ 水浸: 약물을 물에 **담궈** 가용성분이 녹으면 걸러서 사용

└ 水煎: 약물을 물에 **끓여** 가용성분이 우려나면 이를 사용

(2) 작용

: 清潔, 止癢, 退腫, 收斂, 清熱解毒

(3) 적응증

: 급성피부염, **삼출성** or **농성** 분비물이 많은 **피부손상**, 경도의 痂皮性 皮膚損傷.

(4) 상용약물

: **황백**, 포공영, 야국화, 고삼, 울초, **생지유**, 마치현, 다엽 전탕액.

황백은 치자백피탕을 구성하며 피부가 빨갛게 부어오르고 갈라져 삼출물이 나오는 경우에 사용

지유는 화상의 성약으로 피부장벽이 허물어져서 수포가 생기고 터져서 진물이 계속 나오는 경우에 사용

(5) 용법

: 外洗하여 상처를 청결히 씻어주고, 濕敷하면 消炎退腫作用

: 濕敷방법 - 5~6층의 거즈를 약액에 적셔서 환부에 붙이고 1~2시간마다 갈아주며, 약물이 많지 않으면 4~5시간마다 갈아준다.

: 상처를 씻거나 담구거나 찜질하거나 목욕

: 팔다리 병변 - 약물에 담근다, 붕대 / 복부, 등 - 자주 씻거나 목욕하면서 담근다.

☞ 화상 초기에 분말 형태로 환처에 직접 사용할 수 있는 약물? (17)

☞ 급성 피부염에 삼출성 농성 분비물이 나오고 경도 가피성 피부손상에 가장 적절한 외용 제형은? (10)

② 粉劑

(1) 작용

: 保護, 吸收, 蒸發, 乾燥, 止癢

(2) 적응증

: **삼출액**이 없는 급성 or 아급성 피부염

(3) 상용약물

: 청대산, **고반분**, 활석분 백반은 귀에 뿌리면 중이염, 외이도염에 좋다.

(4) 용법

: 매일 3~5차 환부를 두드린다.

(5) 분류

- **소산약** 消散藥 - 창양 초기에 적용

┐ 陽證: 陽毒內消散, 紅靈丹(活血止痛, 消腫化膿)

└ 陰證: 陰毒內消散, 桂麝散(溫經活血, 破堅化膿, 散風祛寒)

- **제농거부약** 提膿祛腐藥

: 瘡瘍의 農毒을 빨리 배출시켜 괴사조직의 신속한 제거

: 대표적 처방 - 九一丹(석고), 九黃丹

- **생기수구약** 生肌收口藥

: 새살이 빨리 돌아나게 하여 瘡口 癒合 촉진

: 대표적 처방 - 生肌散(**황기**, **화분**, 유향, 몰약, 은화, 감초)

황기는 피부장벽을 빠르게 재생시키는 역할을 한다.

- 지혈약 止血藥

: 수술, 외상으로 血脈이 손상되었을 때 사용
: 瘡面에 가루약을 뿌리거나 or 붙여서 止血
: 대표적 처방 - 海浮散(유향, 몰약), 桃花散

③ 洗劑(水劑 + 粉劑 혼합형태)

(1) 작용

: 消炎, 止痒, 保護, 乾燥

(2) 적응증

: **삼출액이 없는** 급성 or 아급성 피부염

(3) 상용약물

: **삼황세제** 洗劑(대황, 황백, 황금, 고삼)

: 靑黛散洗劑(靑黛散 : 증류수 = 3 : 7)

(4) 용법

: 매일 3~5차례 물에 담근 후 충분히 섞어서 바른다.

: 止痒 목적 - + 1% **薄荷** 樟腦 / 살균 목적 - + 5~10% **硫黃**

④ 酏劑

(1) 작용

: **殺真菌**, 止痒

(2) 적응증

: 手癬, 足癬, 甲癬, 體癬, 神經性皮炎

(3) 상용약물

: **복방토근피경** 復方土槿皮酏

(4) 용법

: 현저한 피부손상 or 頭面 軀乾에 사용 자제

: 사용 후에 피부 灼熱感 or 심한 통증

☞ 다음 중 지양, 항균 등의 작용이 있어 무좀, 이질에 사용할 수 있는 약물은? (09)

⑤ 軟膏

(1) 작용

: 保護, 潤滑, 殺菌, 止痒, 痂皮 제거

(2) 적응증

: **만성 피부병** → **結痂, 皸熱, 苔癬樣 변화의 피부손상**

(3) 상용약물

: 靑黛膏, 雄黃膏

(4) 용법

: 거즈에 바른 후 환부에 붙여놓고 싸놓는데, 皸裂이나 苔癬 형태의 피부손상
→ 熱烘療法을 같이 사용하면 효과적

(5) 분류

: 약재 분말 + 물, 기름, 밀가루, 풀, 술로 만든 것

: 성질과 제조 방법에 따라서 硬膏, 軟膏, 藥膏로 구분

- 硬膏

: 국부 종창과 동통 감소, 고름 배출 촉진, 괴사조직 제거

→ 새살이 나오는 것을 촉진

: 가제나 종이에 발라서 국부에 붙이거나 직접 창면에 바른다.

- 軟膏

: **기초제(바셀린, 글리셀린)와 혼합**하고 研製해서 만든다.

원하는 약물을 가루로 만든 뒤 바셀린과 혼합

- 藥膏

: 약재 분말과 물, 술, 밀, 초, 돼지기름을 가온하면서 혼합하여 가제나 종이에 발라서 국부에 붙인다.

: 창상의 후유증 치료에 적용

⑥ 油劑

(1) 작용

: 保護潤滑, 止痒, 乾燥

(2) 적응증

: 미란, 인설, 농포 등이 있는 아급성 피부병 보웬씨병 등에 사용

(3) 상용약물

: **자운고**, 청대산, 삼석산

(4) 용법

: 매일 2~3회 바른다.

: 식물유와 약재분말을 혼합 or 약물을 식물유에 浸, 그리고 나서 煎 + 黃蠟

⑦ 熏蒸劑 nebulizer

: 약을 끓이거나 불에 태울 때 발생하는 蒸氣나 煙氣로써 국부를 지지거나 씌거나 흡입하는 방법

: 피부병, 항문질환 및 난치성 창양에 적용

3) 외치법의 약물 사용법

① 敷法

: 창양 주위에 약을 발라서 치료하는 방법. 고약, 가루약을 이용.

② 噴吹法

: 분무기로 환처에 뿌리는 방법

→ 구강, 이비인후과의 질환에 적용

→ 消腫, 除痰, 止痛, 去腐, 生肌작용을 가진 약재 이용

③ 含水法(爐甘石洗劑)

: 물약을 이용하여 양치질하는 방법

→ 인후, 구강질환에서 미란(+), 고름이 흐를 때 이용

C) 침구치료

1) 鍼刺와 耳鍼

① 작용

: ^{지압}止痒, 止痛, 鎮靜, 安眠, ^{소염}消炎, **모발생장촉진**, 혈관수축조절, 내분비조절

② 상용혈위

(1) 체간

└ 상지: 곡지, 열결, 합곡

└ 하지: 혈해, 음릉천, 삼음교

└ 체간: 폐수, 심수, 비수, 격수

(2) 이침

: 폐, 피질하, 신문, 신상선, 교감, or 병변에 상응하는 혈위

③ 적응증

: 습진, 신경성피부염, 접촉성피부염, 蕁麻疹, 蟲咬皮炎

2) 滾刺療法 MTS

① 작용

: 국부 氣血 소통

② 방법

: 유두층의 신경말초를 파괴하는 동시에 滾刺후 橡皮膏를 바르고 밀봉하면 피부손상 부위가 습한 상태로 유지되어 피부가 유연해져서 潤燥止痒하는 효과

③ 적응증

: 신경성피부염, 만성 태선화병변(건조, 비후, 粗糙), 癢痒性 피부병

D) 理療

1) 烟熏法

- : 약물을 연소한 후에 연기를 취하여 약력과 열력의 작용을 이용하는 방법
- : 피부가 건조해지는 만성 피부병에 사용

2) 熱烘療法

- : 병변부위에 약을 바른 후에 전기드라이어나 불로 말리는 치료법
- : 腠理를 開疎하여 藥力을 滲入시켜 피부가 유연하게 되어 치료되도록 하는데 목적
- : 手足癬 皸裂, 만성습진, 신경성피부염, 반흔, 부스럼 등의 피부건조, 소양감에 사용

3) 藥浴療法

- : 약물 전탕액으로 전신이나 국부에 훈제하는 것
- : 목적 - 藥力과 熱力의 작용을 이용
- : 급성 피부병에서 滲出液이 많을 때는 삼가한다.
- : 적응례
 - ┐ 苦蔘湯 - 만성습진, 銀屑病
 - | 香樟木 - 蕁麻疹
 - └ 生甘草 - 만성습진

4) 物理治療

① 전기 외과술(Electrosurgery)

- : 고주파 전류로 조직을 제거 or 파괴하는 방법
- : 전류의 종류 및 강도에 따라 방전 요법, 전기 건조법, 전기 절개법, 전기 발모법

② 자외선 요법(Ultraviolet Light Therapy)

- : 자외선은 파장이 200~400nm
- : UVA(320~400nm) / UVB(290~320nm) / UVC(200~290nm)

③ 레이저 요법(Laser Therapy)

- : 레이저 광선은 외부에너지를 이용하여 유도방출에 의한 광증폭으로 생기는 광선
- : 레이저 광선의 3가지 특성 - 단색성, 간섭성, 직진성
- : 이러한 특성 때문에 레이저 광선은 많은 양의 광에너지를 목표물에 집중 조사 가능
- : 피부과 영역에서 주로 많이 이용되는 레이저는 CO2 레이저, argon 레이저, ruby 레이저, dye 레이저, copper vapor 레이저 등이다.

+ IPL의 치료 효과 ^{양수구}陽燄灸

- IPL이란?

: Intense Pulsed Light의 약자로 아주 강한 파장의 빛을 주기적으로 방출시켜 여러가지 피부 질환을 치료하는 장비로 우리가 흔히 Laser라고 하지만 엄밀한 의미에서 Laser는 단일 파장에 빛이 나오기 때문에 어떤 한 가지 특정 질환의 치료에 효과적이며 IPL은 동시에 여러 파장의 빛이 조사되므로 다양한 증상에 대하여 치료 및 개선이 가능함.

→ 500~1200nm 파장의 빛이 조사되면 혈관 및 색소질환의 병변 부위가 IPL 빛을 흡수하여 소입자로 파쇄되어 인체 내로 흡수되고 시술 부위가 부드러워지며 피부 탄력이 증대됨

- IPL의 치료 효과

① 색소 병변

: 주근깨, 잡티, 색소침착, 다크서클 등의 색소병변들이 피부 표피에 비교적 얇게 있는 경우 한 번의 치료로도 개선되는 것을 직접 확인할 수 있으며 깊은 층의 색소병변들은 3~5회 이상의 치료 시 개선

→ 문신, 오타씨 반점 등 깊은 색소질환은 치료가 부적절함

② 혈관성 병변

: 안면홍조, 모세혈관확장증, 혈관종 등 혈관성 병변의 경우 종전 레이저 치료 시 발생하는 Purpura(검은색 멍 또는 표피 손상 징후 등)가 발생하지 않아 효과적

③ 제모

: IPL의 광에너지가 피부표면을 통과하면 모근의 멜라닌 색소가 광에너지를 흡수하여 모근에 열 손상을 주게되어 모근을 파괴시키므로 제모에 효과적임

→ 흰색 또는 갈색 제모 치료는 부적절함

④ 여드름

: IPL의 광에너지 및 파장이 피지선을 파괴하거나 피지샘의 피지분비기능을 저하시켜 피지과다분비를 억제하며 여드름에 살균 또는 괴사 효과를 나타냄

⑤ 모공, 여드름 흉터

: 가는 모공이나 작은 여드름 흉터의 경우 IPL 광에너지가 진피층의 콜라겐을 활성화시켜 모공, 여드름 흉터 바닥층에 살이 올라와 피부를 재생시키는 효과가 있음

⑥ 항노화 효과

: IPL이 피부 층에 조사되면 콜라겐 활성화 및 재생 효과로 인하여 피부 노화로 생기는 잔주름 및 피부탄력감소를 완화시켜 탄력과 안면 리프팅 효과가 나타남

이법방의론을 근거로 IPL 치법의 연관성을 가지는 방위는? (18, 17)

rolling scar 형태의 수두형태를 치료하는 방법은? (18, 14)

IPL의 적응증에 해당하지 않는 것은? (12)

IPL의 적응증이 아닌 것은? (09)